

医師が行政で働くということ (国際保健を中心に)

— 名古屋市立大学講義（2026年5月15日） —

厚生労働省 感染症対策部長

鷺見 学 Sumi Manabu MD, MPH, PhD

自己紹介

1996年 名古屋大学医学部卒業

1996年 国立病院（東京災害医療センター、東京医療センター）にて研修医として勤務（1年半のみ）

1997年 厚生労働省入省

※ 診療報酬，食品安全，精神保健，国際保健，がん対策など担当

その間

2004年 公衆衛生学修士（MPH）取得
（ハーバード大学公衆衛生大学院：ボストン）

2007年 医学博士取得（名古屋大学大学院）

2000年～2003年 環境省（環境保健）

2008年～2011年 WHO本部（ジュネーブ）

2011年～2012年 がん対策推進室長

2012年～2014年 国際食品室長（TPP等）

2014年～2017年 国際連合日本政府代表部参事官（ニューヨーク）

2017年～2020年 外務省国際保健政策室長

2020年8月～ 厚生労働省健康局健康課長

2021年9月～ 厚生労働省医政局地域医療計画課長

2023年7月～ 内閣官房内閣感染症危機管理統括庁内閣審議官

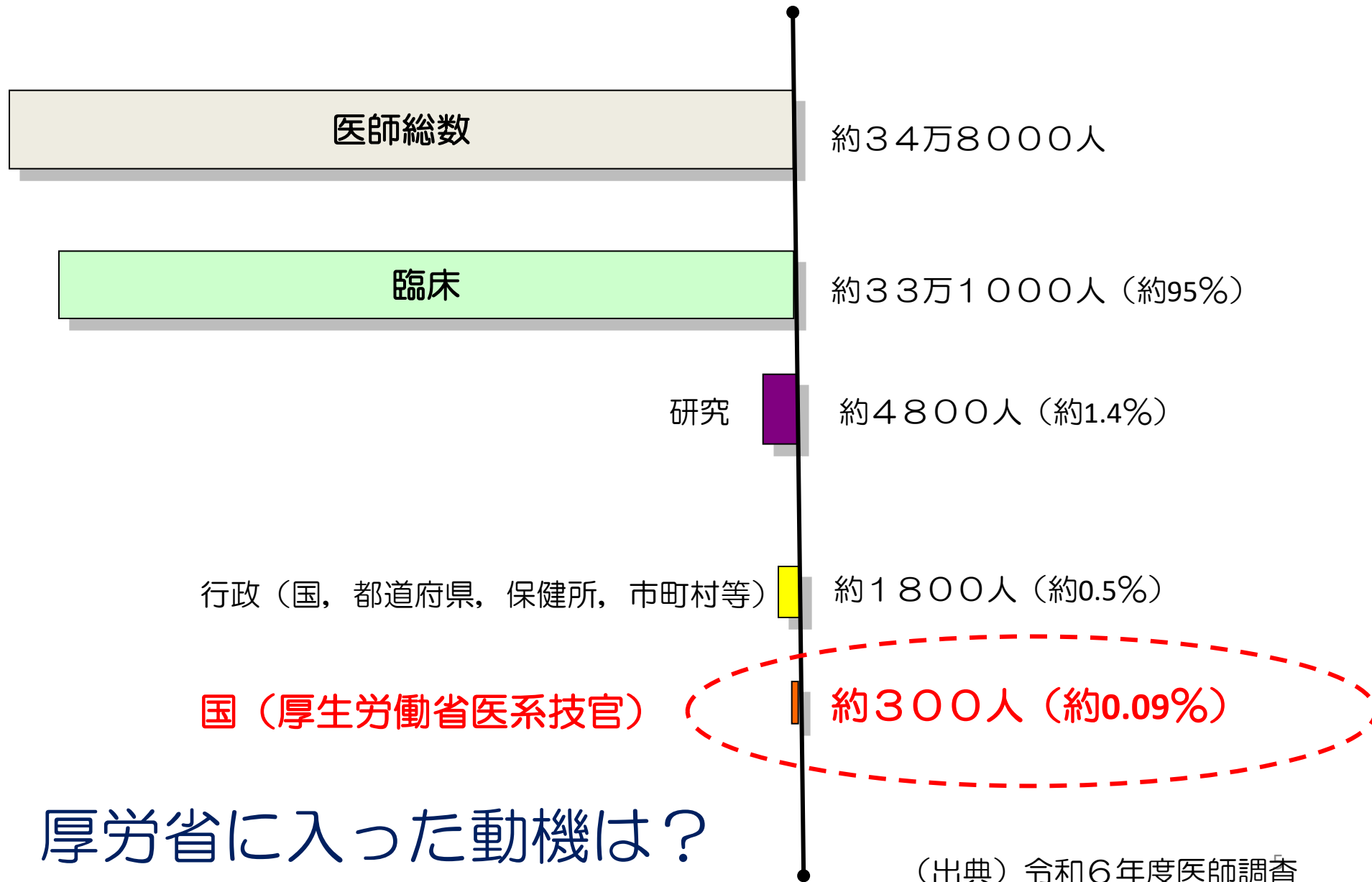
2024年7月～ 厚生労働省感染症対策部長

本日のレクチャーのアウトライン

- 医系技官とは？
- 国外における経験
 - ハーバード公衆衛生大学院（ボストン）
 - WHO本部事務局（ジュネーブ）
 - 国連代表部（ニューヨーク）
 - JPO制度
 - MDG、SDG、国際保健アクター
- 地域医療構想
- 感染症対策
- 最後に

医系技官とは？

「医師」はどこで働いているか？



厚生労働省 医系技官

- 人々の健康を守るため、医師免許（歯科医師免許）を有し、専門知識をもって、保健医療に関わる仕組み作りの中心として活躍する技術系行政官

政策立案から実施まで全てのプロセスに関わります

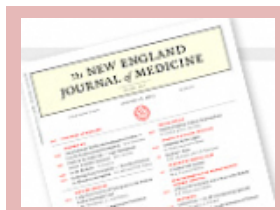
政策の立案

政策の決定



現場視察

科学的根拠の収集



研究班の立ち上げ

審議会での議論



現場の視点
専門的議論



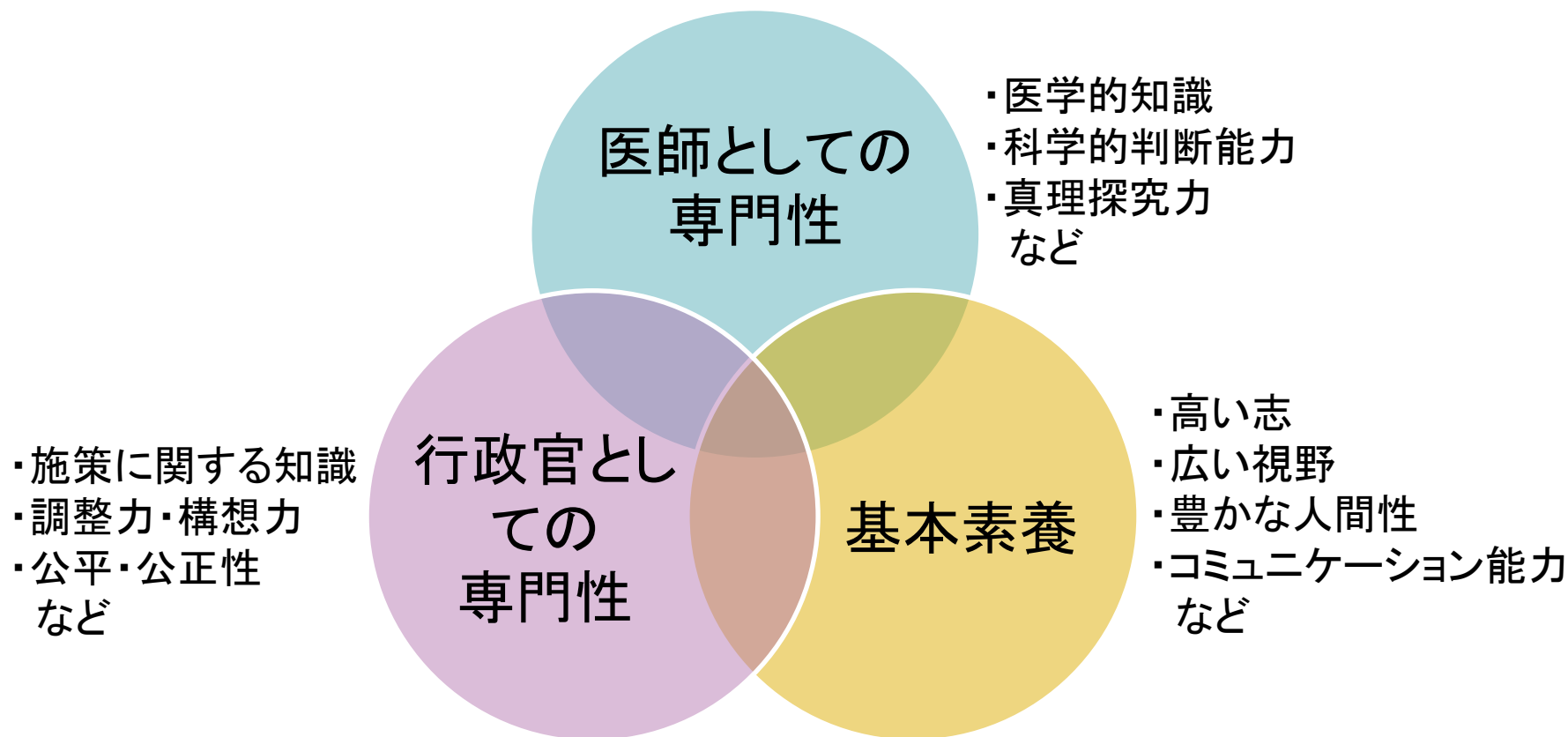
政策案・法案や
予算案の立案



政策決定
(予算、法案)

政策の
実施

「医師としての専門性」と「行政官としての専門性」の両方が必要とされます



この方も医系技官の大先輩



後藤 新平（1857－1929年）
医師
官僚（内務省衛生局長：35歳）
政治家

帝都復興院総裁として、大震災後の
東京復興計画を立案

※この他、

- 「衛生」の名付け親の長興専齋
- 1964年の東京オリンピックの際
の東京都知事の東龍太郎
などもいる

全体で約300名

(最大の医局?)

■厚生労働本省 約 200名

- 医務技監
- 医政局長，健康・生活衛生局長，総括審議官（危機管理・医務技術），**感染症対策部長**，審議官（保険局），国際保健福祉交渉官
- 厚生科学課長，地域医療計画課長，医事課長，研究開発政策課長，健康課長，がん・疾病対策課長，感染症対策課長，予防接種課長，血液対策課長，労働衛生課長，精神・障害保健課長，医療課長，老人保健課長 他

■他省庁，地方自治体，関係機関等 約 100名

- 内閣官房（内閣審議官），内閣府（内閣審議官），こども家庭庁，消防庁，法務省，文科省，環境省（環境保健部長、水・大気担当審議官），防衛省（衛生監），外務省，原子力規制庁，復興庁，人事院
- 都道府県・政令市（健康福祉部長等）
- 地方厚生局，国立感染症研究所，検疫所，保健医療科学院
- AMED，がん/成育医療/精神・神経/国際医療センター，PMDA 等
- 国内大学（自治医）・海外留学（ハーバード大，ロンドン大等）
- 大使館，国際連合日本政府代表部，寿府代表部，WHO，CDC等

「未来を創る」挑戦



厚生労働省 医系技官 採用情報

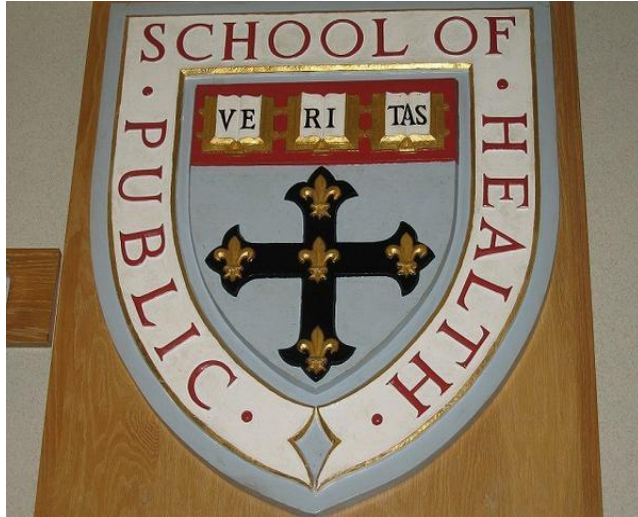


Working for Public Health

皆さんのチャレンジを
医系技官一同
お待ちしております

国外における経験

ハーバード公衆衛生大学院（ボストン）



ハーバードには10の大学院（ビジネススクール，ケネディ（行政学）スクール，ロースクール，メディカルスクール，デンタルスクール，デザインスクール，教育学，工学，神学，公衆衛生学）がある。



- 日本ではマイナーな学問（医学部の中の一教室であることが多い）
- 学生（修士・博士過程）計900名に対して教師400名，研究者600名。
- 公衆衛生の範囲の広さ（環境保健，道路安全，社会疫学（イチロー・カワチ）等），専門性の深さ（生物統計が日進月歩であること等。New England Journal of Medicineの本部が存在）に気づく

WHO本部事務局（ジュネーブ）



- Norm（規範，ガイドライン等）づくり
 - 厚労省の仕事との違いは？
 - ↔ フィールド活動
 - （エボラ対応の反省→国事務所の強化）
 - 民間企業との連携に慎重
 - （Conflict of Interest）
 - 専門性の高さが武器
- ワーク・ライフバランス
 - 仕事に対する考え方，働き方の違い
 - 優秀な人材を確保できる環境

エーザイからの貢献

PPP (Public Private Partnership)



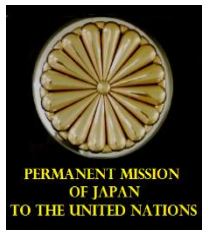
Neglected tropical diseases

WHO to receive more than 2 billion tablets as contribution to help eliminate lymphatic filariasis

18 November 2010 | Tokyo

The World Health Organization (WHO) today signed a statement of intent with the pharmaceutical company Eisai Co., Ltd. for the supply of up to 2.2 billion tablets of an anti-filarial medicine, diethylcarbamazine (DEC). This medicine will be distributed free of charge with albendazole to help interrupt transmission of lymphatic filariasis, also known as elephantiasis. Lymphatic filariasis puts more than one billion people in poor countries at risk of infection.





国連代表部（ニューヨーク）

- 「国連を通じた国際の平和と安定の維持への貢献」などの目的を実現するために国連の場で交渉する等の任務を行う。
- 国連職員ではなく、日本政府（外務省）の国家公務員。
- 世界中のほとんどの国が国連代表部を国連本部近くに置き、各国の外交官や国連機関職員等と情報交換、交渉を行う。
- 日本政府は、国連代のほか、ASEAN代表部、OECD代表部、EU代表部、在ジュネーブ国際機関代表部など計9つの代表部を設置。（大使館を置いている国は194か国（実際にその国に存在するのは139か国））



国連代表部の仕事

- 日本政府としてふさわしい支援を行うための判断のもととなる情報収集・分析結果を提示
- 国内施策を行うための判断にも貢献
- 現地日本大使館からの公電情報はもとより、各国や国連機関（WHO, UNICEF等）のウェブサイト、CDCなど専門機関の情報、これら関係者からの聞き取り、新聞等のマスメディア情報等から全体像を把握
- 日本の支援を世界にわかりやすい形で公表

国連代表部が考慮した主な事項

- 現地における実際の状況，必要な支援
- 他のドナー国の支援の状況
- 地域文化（埋葬など）や偏見への対応
- 科学的エビデンス（感染経路，精液：不確実さを含め）
- 検疫，入国管理
- ワクチン，治療薬，診断機器（治験，開発，実用性等）
- 交通網
- 緊急避難
- 軍隊（自衛隊）
- 透明性高い貢献（納税者への説明責任）
- 情報発信の重要性（日本政府のプレゼンス↑，他国からの支援を引き寄せる）

会議の状況



決議案交渉

United Nations

A/70/L.32



General Assembly

Distr.: Limited
10 December 2015

Original: English

Seventieth session

Agenda item 125

Global health and foreign policy

Brazil, France, Indonesia, Japan, Norway, Senegal, South Africa, Switzerland and Thailand: draft resolution

Global health and foreign policy: strengthening the management of international health crises

The General Assembly,

Recalling its resolutions 63/33 of 26 November 2008, 64/108 of 10 December 2009, 65/95 of 9 December 2010, 66/115 of 12 December 2011, 67/81 of 12 December 2012, 68/98 of 11 December 2013 and 69/132 of 11 December 2014,

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights,¹ international humanitarian law, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights² and the Constitution of the World Health Organization,³

Taking note of the presidential statement adopted by the Human Rights Council at its thirtieth session on promoting the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health through enhancing capacity-building in public health against pandemics,⁴

Recognizing that health is a precondition for and an outcome and indicator of all three dimensions of sustainable development and that, despite progress made, challenges in global health, including major inequities and vulnerabilities within and among countries, regions and populations, still remain and demand persistent attention,

20. *Encourages* Member States to participate actively in the dissemination, verification and validation of surveillance data and information concerning public health emergencies and, in close collaboration with the World Health Organization, to exchange information and experience in a timely and open manner on epidemics and the prevention and control of emerging and re-emerging infectious diseases that pose a risk to global public health;

21. *Calls upon* the international community and Member States to give due consideration to the importance of the management of international health crises, bearing in mind the social, economic, security and environmental implications of the policy choices and actions of Member States at all levels in their implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business;

22. *Requests* the Secretary-General, as appropriate, in consultation with Member States, relevant international organizations and other relevant actors, to explore steps to meet the global shortfall of trained health workers, including the possibility of establishing a high-level commission on future health employment and economic growth;

23. *Also requests* the Secretary-General, in close collaboration with Member States, the Director General of the World Health Organization and the United Nations system, to submit a report on the lessons learned in the public health emergency response to and management of previous international crises with health consequences, and to transmit in 2016 and 2017 reports provided by the World Health Organization on the state of health security, taking into account deliberation by the World Health Assembly on the matter, and acknowledging that the ongoing necessity of such reports beyond 2017 can be re-evaluated.

JPO派遣制度



JPO派遣制度



JPO生の声は[こちら](#)

- ▶ JPO派遣制度
- ▶ JPOの派遣先国際機関
- ▶ JPO派遣制度 (PDF )
- ▶ JPO募集
- ▶ (参考)2026年度(令和8年度) JPOポストのリスト
- ▶ Q & A

JPO (Junior Professional Officer) 派遣制度は、

1961年の国連経済社会理事会決議により設けられ、各国政府の費用負担を条件に国際機関が若手人材を受け入れる制度です。日本も外務省を含む複数の省庁が、国連をはじめとする国際機関に派遣を実施しています。

外務省では、1974年から同制度による派遣を開始し、35歳以下の若手の日本人に対し、**2年間国際機関で勤務経験を積む機会**を提供しています。これまでの累計派遣者数は2000名以上。JPOは派遣期間中に、国際機関職員として必要な知識・経験を積み、**派遣期間終了後に正規採用**を得ることが期待されています。ただし、自動的に国際機関の正規職員となることが保証されるものではありませんので、派遣期間終了後に正規職員となるためには、通常の手続きに従って空席ポストに応募して採用される必要があります。

ミレニアム開発目標(MDGs)

2001年に策定された国連開発目標。2015年が達成期限。

8つの目標のうち3つが保健関連の目標



目標1：極度の貧困と飢餓の撲滅



目標2：初等教育の完全普及の達成



目標3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上



目標4：乳幼児死亡率の削減



目標5：妊産婦の健康の改善



目標6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止



目標7：環境の持続可能性確保



目標8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進



REDUCE
CHILD MORTALITY

4

予防可能な疾病による幼児死亡数の著しい低下は、人類史上で最も偉大な成果

目標：幼児死亡率の引き下げ

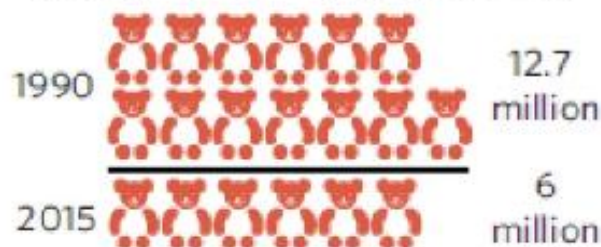


Photo: © UNICEF/Esiebo

1990年代初頭以降、5歳未満の幼児死亡率改善のペースは世界規模で3倍に加速している。

世界における5歳未満の幼児死亡率は、1990年から2015年の間に生まれた1,000人あたり90人から43人へと、半分以下に減少した。

5歳未満の子どもの世界的な死亡数



はしかの予防接種は、2000年から2013年の間に1,560万人の死亡を防いだ。



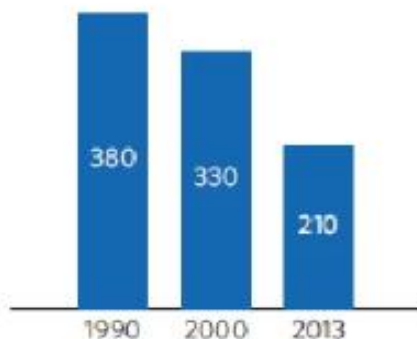
5

IMPROVE MATERNAL
HEALTH

妊産婦の健康状態に一定の改善が見られた

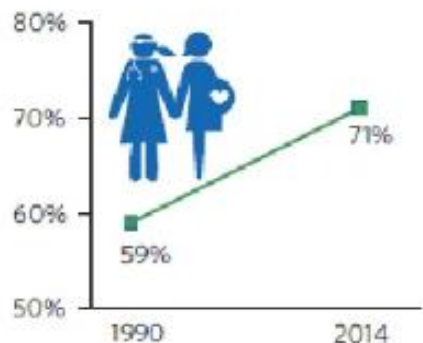
目標：妊産婦の健康状態の改善

世界の妊産婦死亡率 (出産10万対)



1990年以降、妊産婦の死亡率は45%減少した。これらの減少の多くは2000年以降に起こっている。

医療従事者の立会いの下に行われた出産



2014年には、世界の71%以上の出産は、医療従事者の立会いの下に行われた。これは1990年の59%から、目立った上昇である。



6

COMBAT HIV/AIDS,
MALARIA AND OTHER
DISEASES

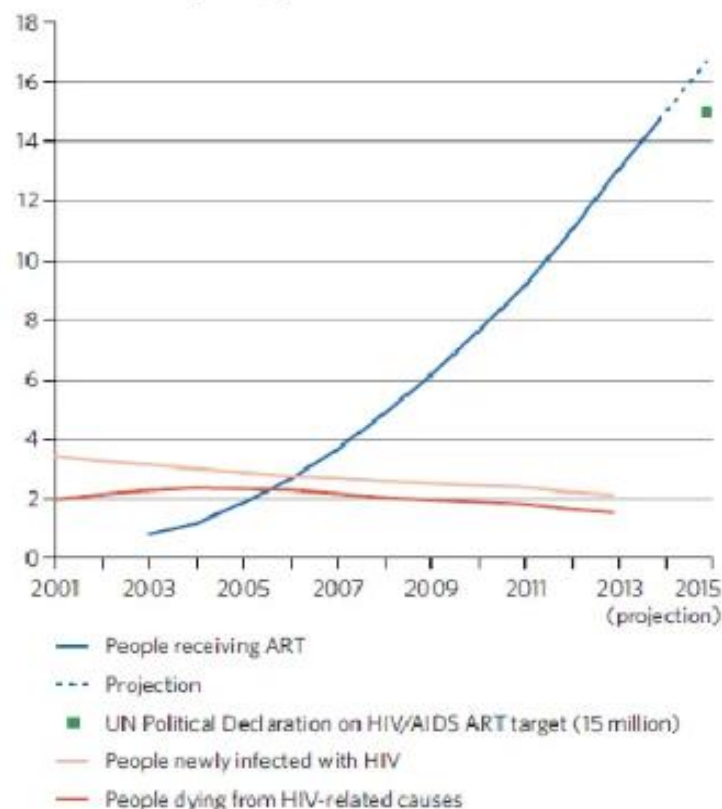
HIV感染者が世界の多くの地域で減少

目標: HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止

HIVへの新たな感染は2000年から2013年の間で約40%低下し、感染者数も約350万人から210万人へ減少した。

2014年6月までに世界中で1,360万人のHIV感染者が抗HIV療法を受けていたが、これは2003年の80万人から飛躍的な進歩である。抗レトロウイルス療法によって1995年から2013年までの間に760万人がHIVによる死から免れた。

抗レトロウイルス療法を受けている人数, 2003-2015, エイズ関連起因による死亡数と新たにHIVに感染した人数, 2001-2013 (100万)





6

COMBAT HIV/AIDS,
MALARIA AND OTHER
DISEASES

マラリアと結核のまん延が止まり、減少

目標: HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止

サハラ以南アフリカにおける殺虫剤処理された蚊帳の配布数(2004-2014年)



2000年から2015年の間に、620万人以上の人々がマラリアによる死を免れた。その多くが、サハラ以南のアフリカに住む5歳未満の子どもたちである。

2004年から2014年までの間に、**9億以上もの殺虫剤処理された蚊帳**が、マラリアが風土病となっているサハラ以南アフリカの国々に配布された。

2000年から2013年の間に、結核の予防、診断、治療によって、**約3,700万人の命**が救われた。

持続可能な開発目標(SDGs)

- 2015年9月の国連サミットで全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標。(その下に、169のターゲット、231の指標が決められている。)



普遍性 先進国を含め、全ての国が行動

包摂性 人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」

参画型 全てのステークホルダーが役割を

統合性 社会・経済・環境に統合的に取り組む

透明性 定期的にフォローアップ

前身：ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)

- ▶ 2001年に国連で専門家間の議論を経て策定。2000年に採択された「国連ミレニアム宣言」と、1990年代の主要な国際会議で採択された国際開発目標を統合したもの。
- ▶ 開発途上国向けの開発目標として、2015年を期限とする8つの目標を設定。
(①貧困・飢餓、②初等教育、③女性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連帯)

- ✓ MDGsは一定の成果を達成。一方で、未達成の課題も残された。
 - 極度の貧困半減(目標①)やHIV・マラリア対策(同⑥)等を達成。
 - × 乳幼児や妊産婦の死亡率削減(同④、⑤)は未達成。サブサハラアフリカ等で達成に遅れ。



3. すべての人に健康と福祉を

- 3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。
- 3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳未満死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指す。
- 3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を終息するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
- 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。
- 3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。
- 3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
- 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できる。
- 3.8 すべての人々に質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。
- 3.9 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病を減らす。
- 3.a すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
- 3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。
- 3.c 開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。
- 3.d すべての国々で健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。

国際保健分野での取組：国際保健の主要なアクター

Gaviワクチンアライアンス（ニシュタール事務局長）
→ワクチン供給による感染症対策、保健システム強化

※日本は理事

グローバルファンド

（サンズ事務局長）

→エイズ、結核、マラリア対策、
保健システム強化

※日本は理事

ユニットエイド

（デュストン事務局長）

→三大感染症等の医薬品研究・
開発やアクセス改善のための
イノベーション支援

※日本は暫定理事

グローバルヘルス 技術振興基金 (GHIT)

（國井CEO）

→顧みられない熱帯病等の
医薬品研究開発を支援

※日本は理事

官民連携基金
による資金支援

国連機関及び
国際金融機関
による支援

日本の 国際保健戦略

国際NGO/民間財団等との協力

世界保健機関 (WHO)（テドロス事務局長）
→保健に関する規範やルール作り、技術
支援等でリーダーシップ

※主要関係機関を例示
国連本部 (UNHQ)
（グテーレス事務総長）

国連持続可能な開発グループ (UNSDG)

（議長：モハメッド国連副事務総長）

→保健含む国連開発担当機関とりまとめ

国連児童基金 (UNICEF)

（ラッセル事務局長）

→子どもの保健・栄養・水・教
育及び緊急人道支援

※日本は理事

国連人口基金 (UNFPA)

（カネム事務局長）

→女性の保健・人口に関する
疾病政策

※日本は理事

国連合同エイズ計画 (UNAIDS)

（ビヤニマ事務局長）

→エイズ対策、関係者の調整

※日本は理事

世界銀行グループ (WBG)

（バング総裁）

→保健制度支援等

※日本は理事

民間財団

（例）**ビル＆メリンダ・ゲイツ財団**

（ゲイツ共同議長）

→世界の疾病や貧困の克服

国際NGO

（例）**国際家族計画連盟 (IPPF)**

（ベルメホ事務局長）

→性と生殖に関する健康及び権利
等に関する支援

（例）**国境なき医師団**

（クリストウ会長）

→緊急医療援助

マルチステークホルダーの連携枠組

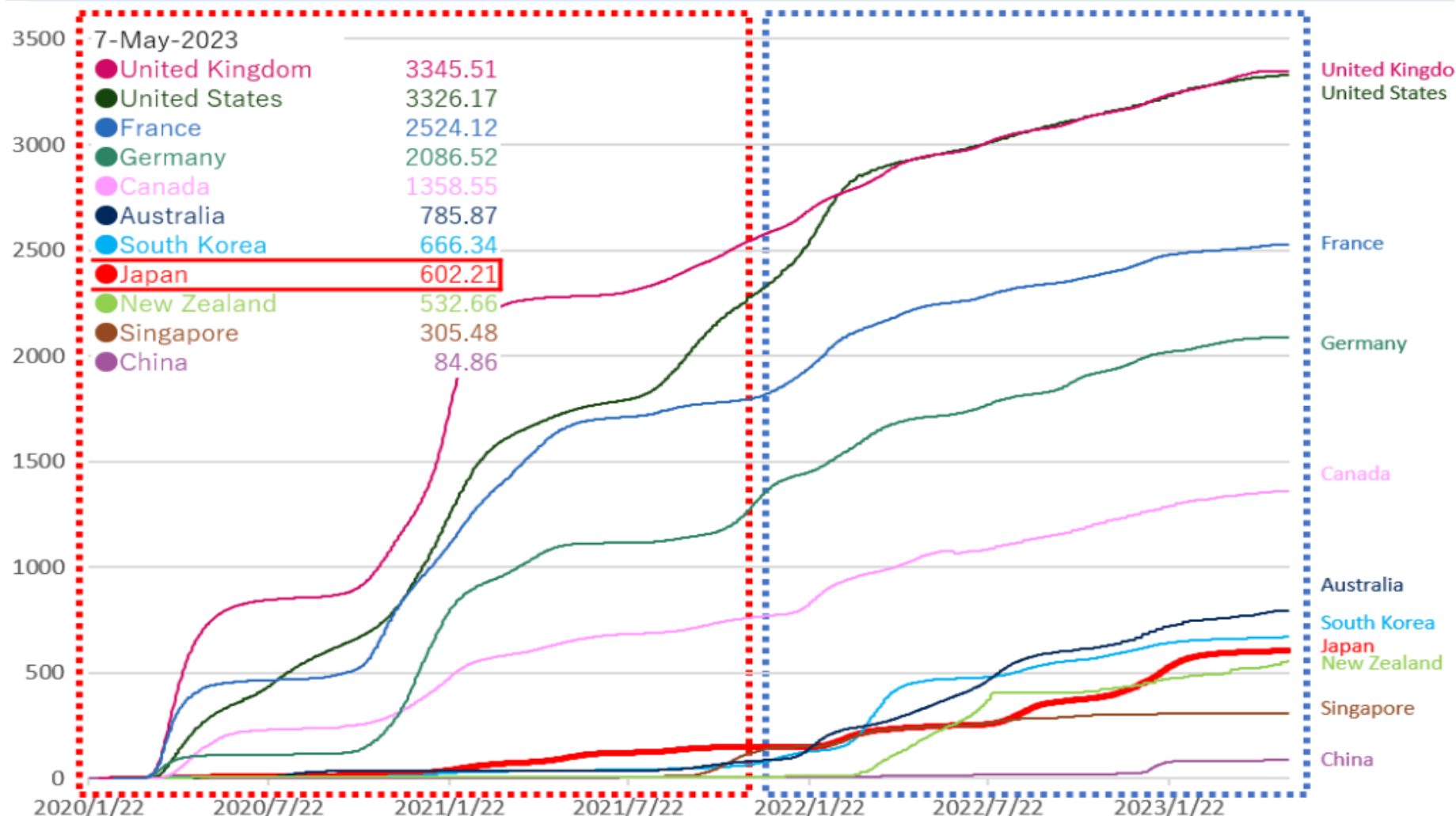
UHC2030

（ステアリング委員会共同議長：
ロバロ氏並びにシプリアーノ氏）

→UHC達成を目標とした連携枠組

新型コロナ対策

主要各国の感染動向（2020/1/22～2023/5/7）【累積死亡者】

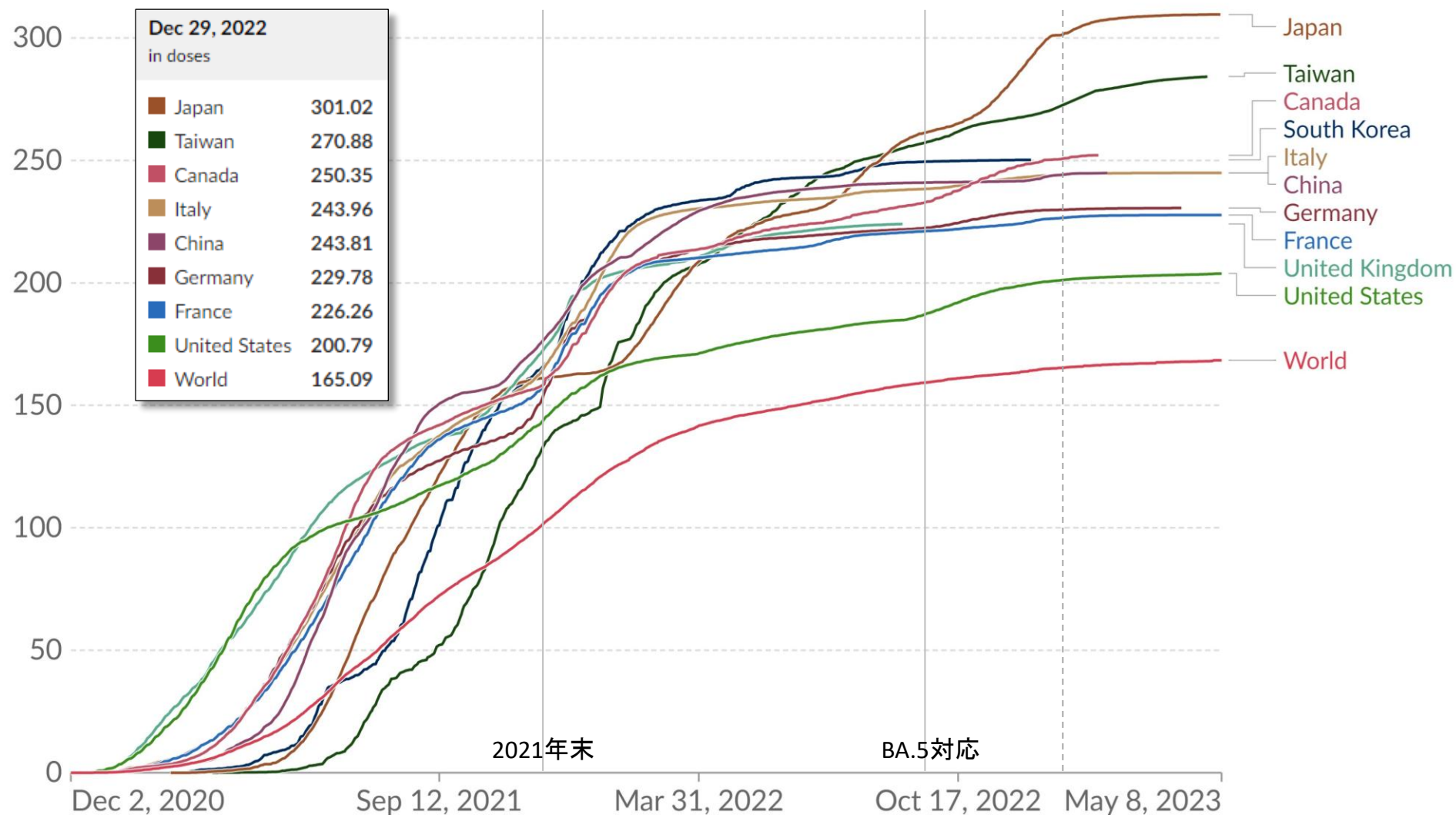


出典：Our World in Data

※1：100万人あたりの人数

※2：報告数については、各国の状況により過少報告になっている可能性があることに留意

人口100人当たりのワクチン接種数



Data source: Official data collated by Our World in Data – Last updated 15 November 2023

OurWorldInData.org/coronavirus | CC BY

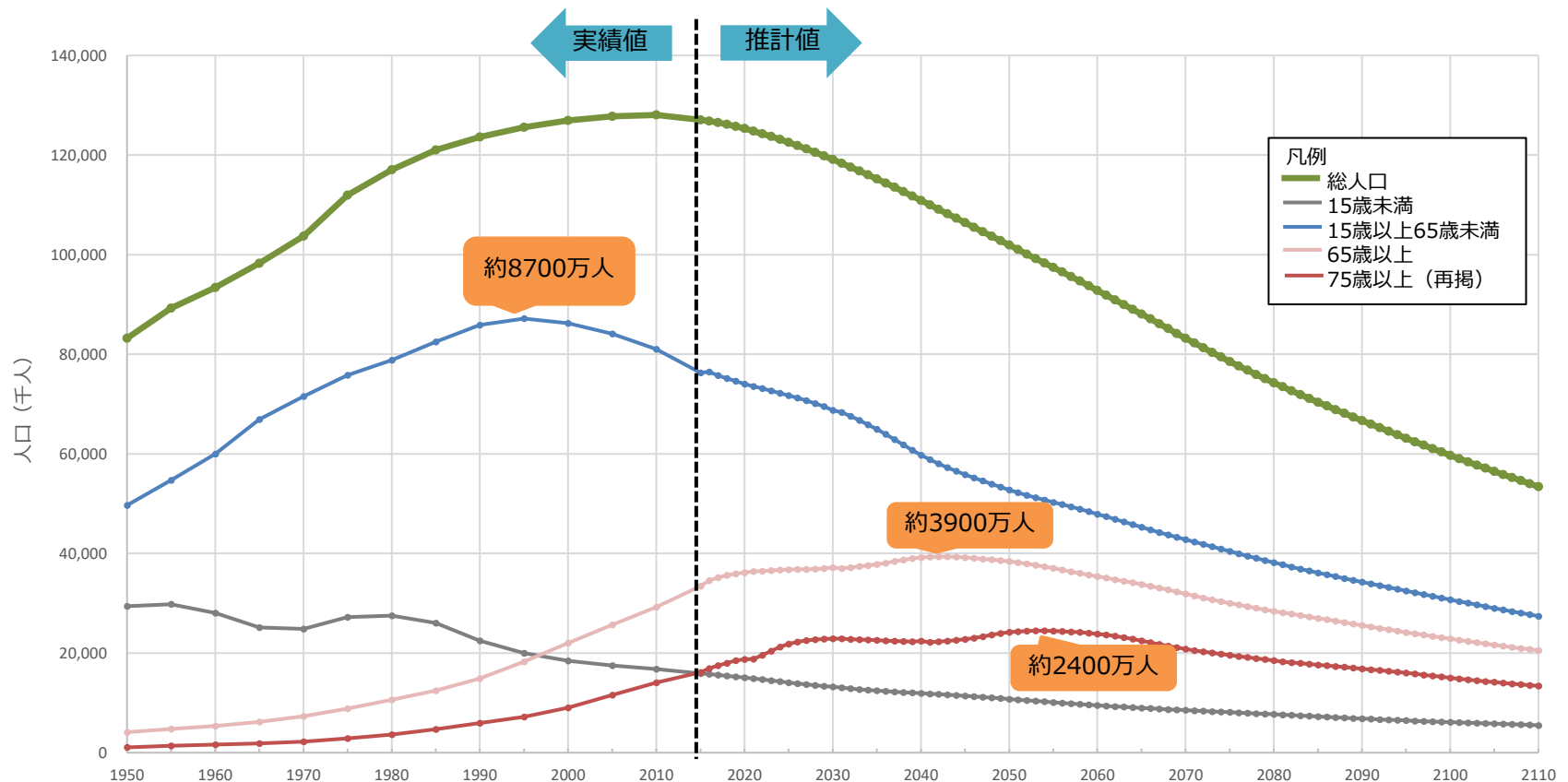
地域医療構想

(20年後の医療提供体制を見据える)

人口動態① 2040年頃に65歳以上人口のピークが到来する

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 我が国の人口動態を見ると、現役世代（生産年齢人口）の減少が続く中、いわゆる団塊の世代が2022年から75歳（後期高齢者）となっていく。
- その後も、2040年頃まで、65歳以上人口の増加が続く。



出典：国立社会保障・人口問題研究所「年齢（4区分）別人口の推移と将来推計」「総数、年齢4区分別総人口および年齢構造係数」

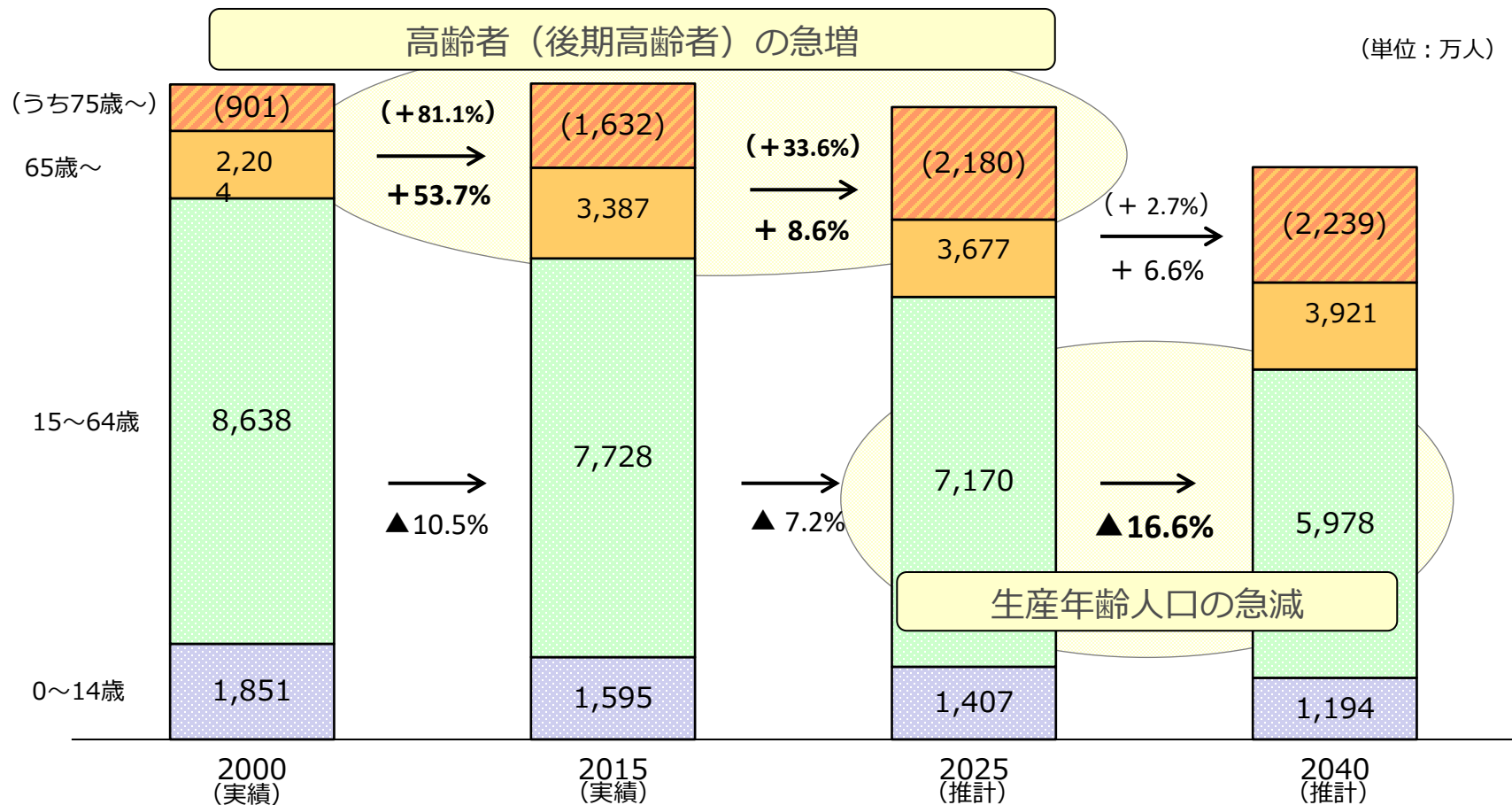
※ 2015年までは国勢調査の実績値、2016年以降は推計値。

人口動態② 2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化する

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 2025年に向けて、高齢者、特に後期高齢者の人口が急速に増加した後、その増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている生産年齢人口は、2025年以降さらに減少が加速する。

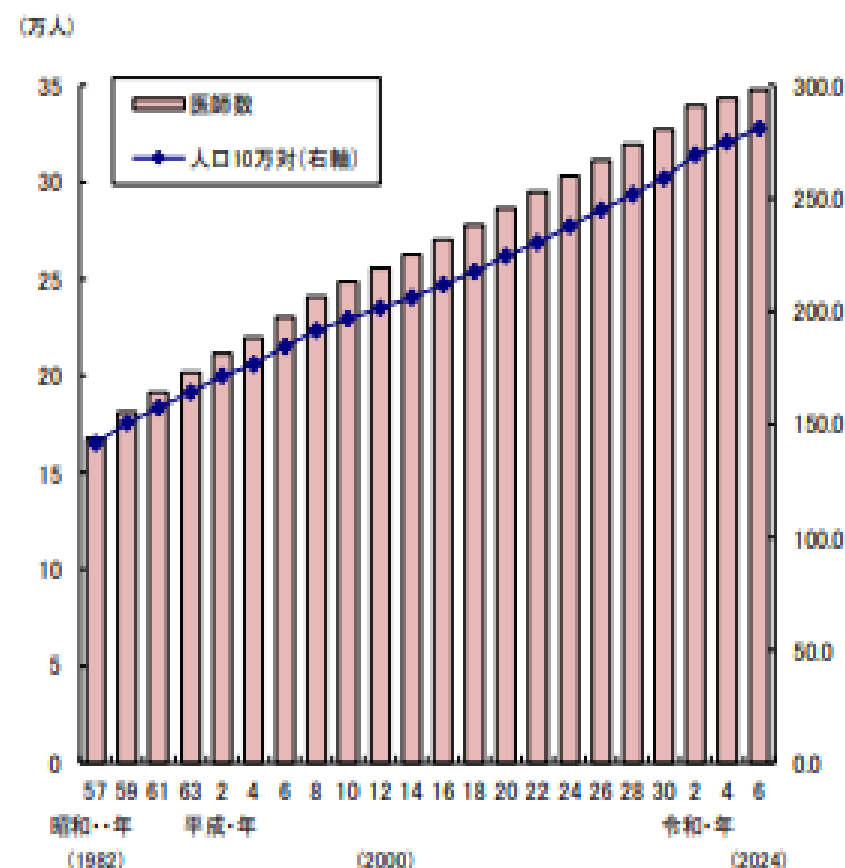
【人口構造の変化】



医師・歯科医師・薬剤師数の年次推移

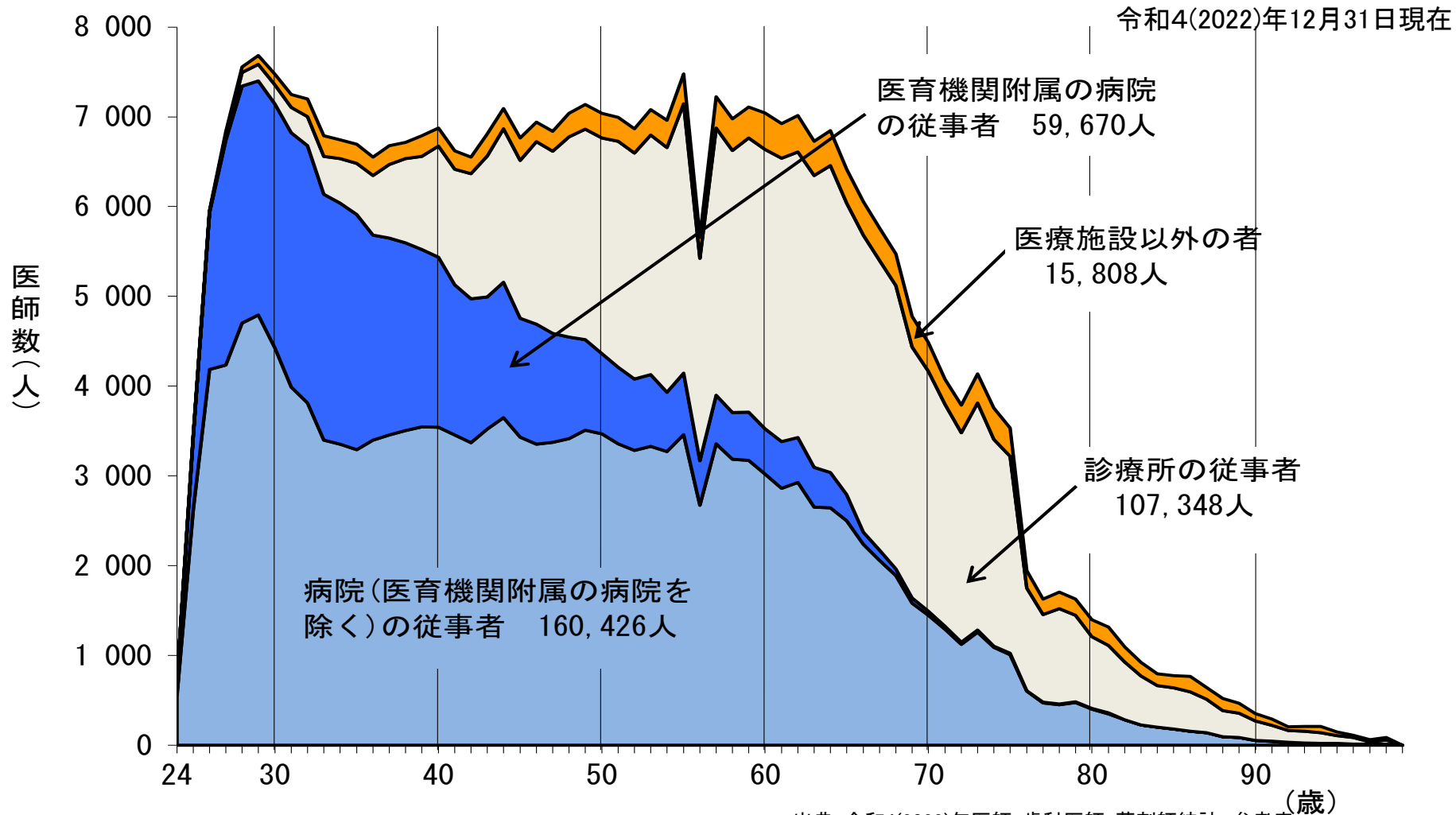
各年12月31日現在

	医師数 (人)	増減率 (%)	人口10万対
昭和 57 年 (1982)	167 952	---	141.5
59 ('84)	181 101	7.8	150.6
61 ('86)	191 346	5.7	157.3
63 ('88)	201 658	5.4	164.2
平成 2 年 ('90)	211 797	5.0	171.3
4 ('92)	219 704	3.7	176.5
6 ('94)	230 519	4.9	184.4
8 ('96)	240 908	4.5	191.4
10 ('98)	248 611	3.2	196.6
12 (2000)	255 792	2.9	201.5
14 ('02)	262 687	2.7	206.1
16 ('04)	270 371	2.9	211.7
18 ('06)	277 927	2.8	217.5
20 ('08)	286 699	3.2	224.5
22 ('10)	295 049	2.9	230.4
24 ('12)	303 268	2.8	237.8
26 ('14)	311 205	2.6	244.9
28 ('16)	319 480	2.7	251.7
30 ('18)	327 210	2.4	258.8
令和 2 年 ('20)	339 623	3.8	269.2
4 ('22)	343 275	1.1	274.7
6 ('24)	347 772	1.3	280.9



施設の種別・年齢別にみた医師数（R4）

○令和2年に比べ令和4年は、病院（医育機関附属の病院を除く）の従事者は約1,430人増加、医育機関附属の病院の従事者は約2,190人増加している。診療所の従事者は、約120人増加となっている。



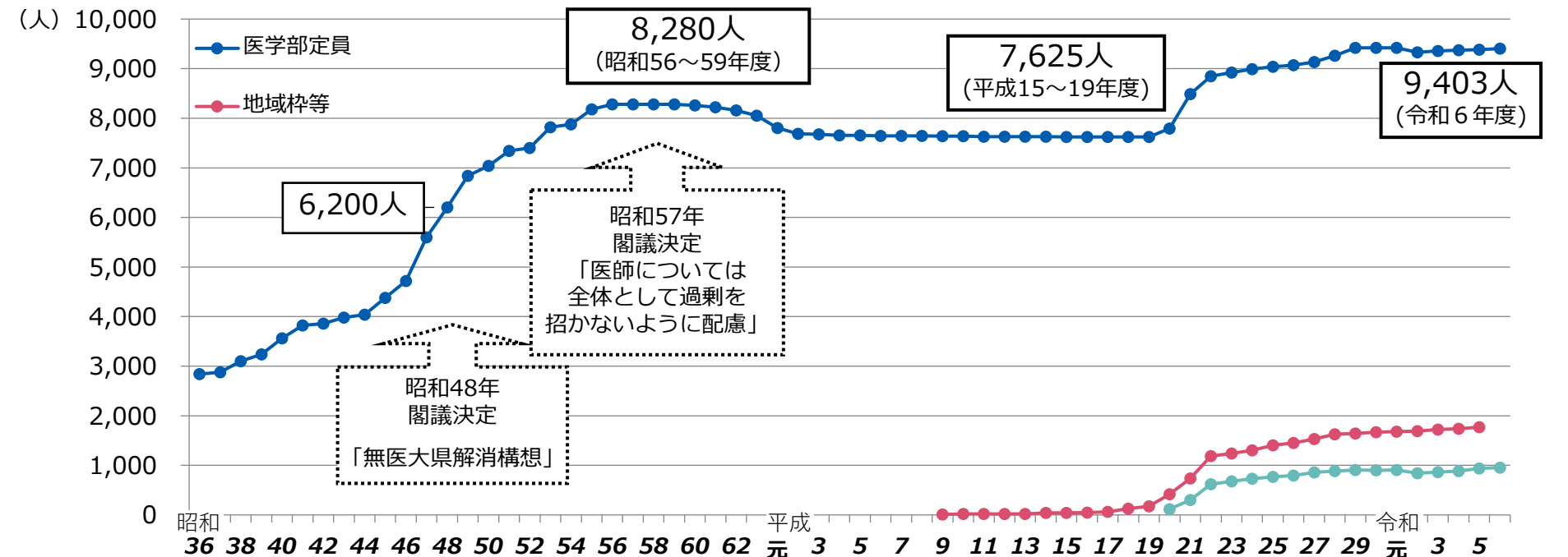
出典: 令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計 参考表
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/xls/R04_sankou.xlsx

医学部入学定員と地域枠の年次推移

第2回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
令和6年2月26日
資料1

- 平成20年度以降、医学部の入学定員が過去最大規模となっており、令和2年度以降、前年度比増が継続している。
- 医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度173人（2.3%）→令和4年1,736人（18.8%））

※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠



	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
医学部定員	7,625	7,793	8,486	8,846	8,923	8,991	9,041	9,069	9,134	9,262	9,420	9,419	9,420	9,330	9,357	9,374	9,384	9,403
医学部定員（自治医科大学を除く）	7,525	7,683	8,373	8,733	8,810	8,868	8,918	8,946	9,011	9,139	9,297	9,296	9,297	9,207	9,234	9,251	9,261	9,280
地域枠等以外の医学部定員	7,452	7,375	7,750	7,660	7,681	7,687	7,635	7,619	7,603	7,635	7,775	7,745	7,733	7,635	7,634	7,638	7,614	—
地域枠等	173	418	736	1,186	1,242	1,304	1,406	1,450	1,531	1,627	1,645	1,669	1,682	1,688	1,723	1,736	1,770	—
地域枠等の割合	2.3%	5.4%	8.8%	13.6%	14.1%	14.7%	15.8%	16.2%	17.0%	17.8%	17.7%	18.0%	18.1%	18.3%	18.7%	18.8%	19.1%	—
地域枠等を要件とした臨時定員	0	118	304	617	676	731	770	794	858	886	904	903	904	840	865	885	938	955
地域枠等を要件とした臨時定員の割合	0%	1.5%	3.6%	7.1%	7.7%	8.2%	8.6%	8.9%	9.5%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.1%	9.4%	9.6%	10.1%	10.3%

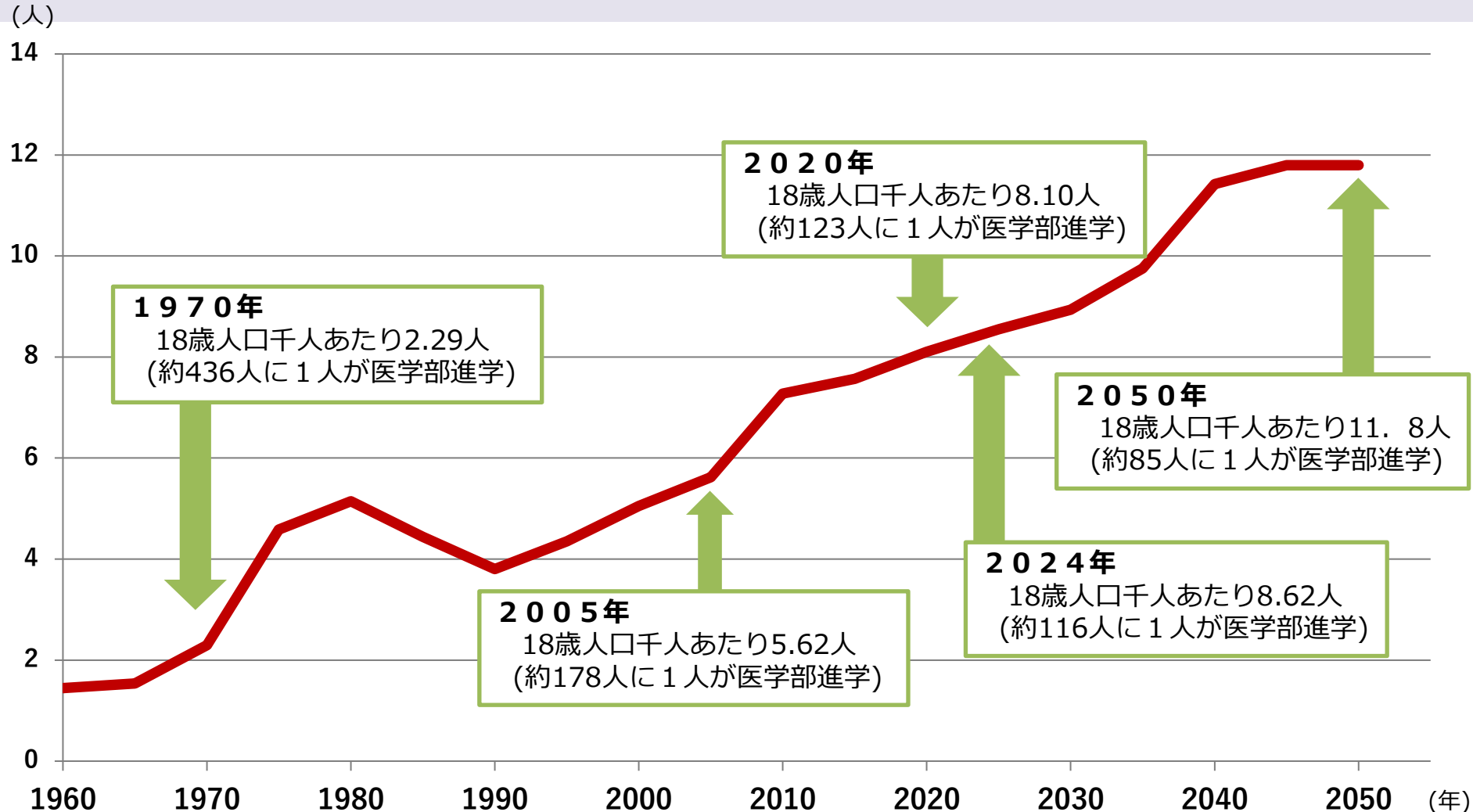
※自治医科大学は、設立の趣旨に鑑み地域枠等からは除く。

（地域枠等及び地域枠等を要件とした臨時定員の人数について、令和5年文部科学省医学教育課調べ） 37

18歳人口千人あたりの医師養成数

第2回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
令和6年2月26日
資料1

- 1970年は約436人に1人が医学部進学していたところ、2024年度の募集定員数で固定した場合、2050年には約85人に1人が医学部進学することとなる。



※18歳人口は1960～2020年までが国勢調査、2021年以降は日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所令和5年推計 出生中位・死亡中位）を使用。

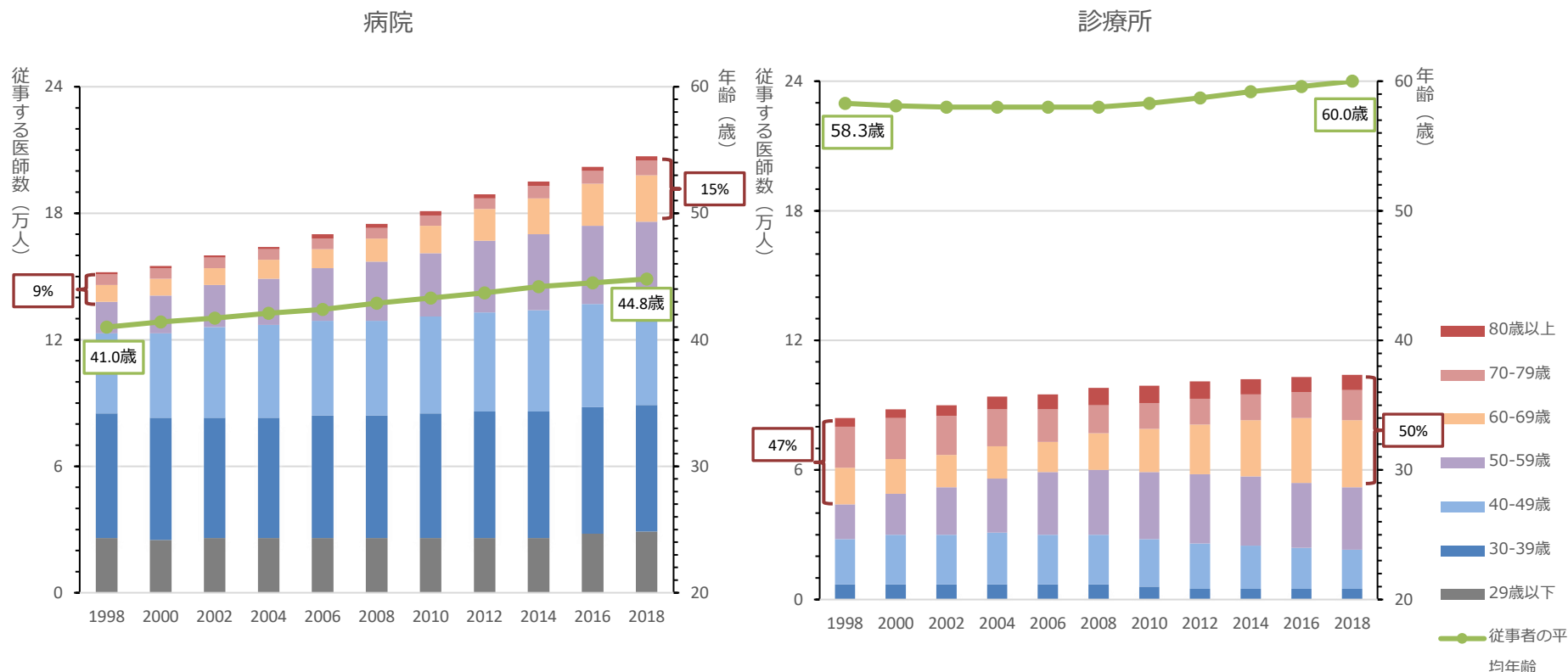
※医学部定員に関しては、2024年度の定員数で固定されたと仮定。

マンパワー③ 提供者側（医師）の高齢化も進展している

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 病院に従事する医師数は、ここ20年で5.5万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は15%に増加しており、平均年齢は44.8歳まで上昇している。
- 診療所に従事する医師数は、ここ20年で2.0万人増加しているが、60歳以上の医師が占める割合は50%程度で、平均年齢は60.0歳まで上昇している。

年齢階級別にみた病院従事する医師数及び平均年齢の年次推移

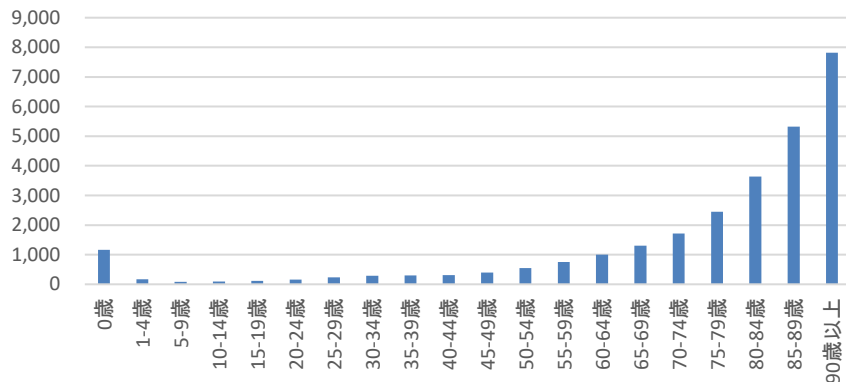


医療需要の変化① 入院患者数は、全体としては増加傾向にある

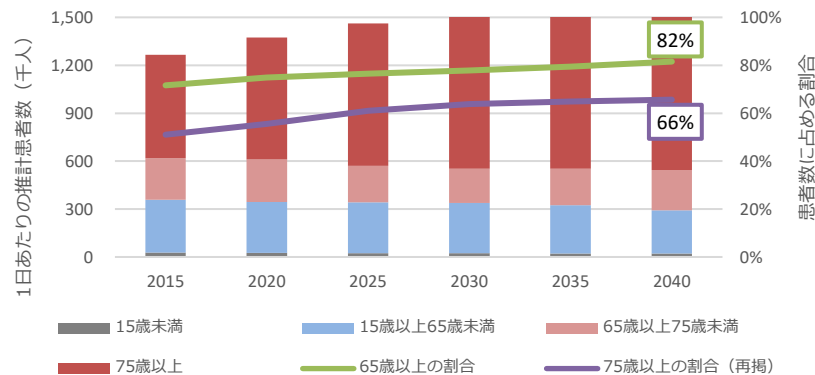
令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 全国での入院患者数は2040年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続的に上昇し、2040年には約8割となるが見込まれる。
- 2次医療圏によって入院患者数が最大となる年は様々であるが、既に2020年までに90の医療圏が、また2035年までには261の医療圏がピークを迎えることが見込まれる。

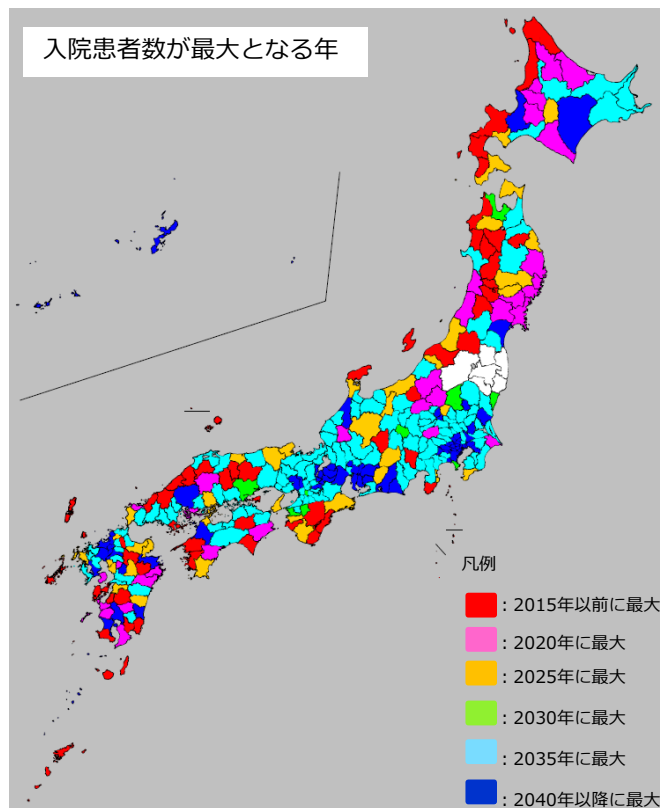
入院受療率（人口10万対）



入院患者数推計



入院患者数が最大となる年



出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院一外来×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用いて算出。

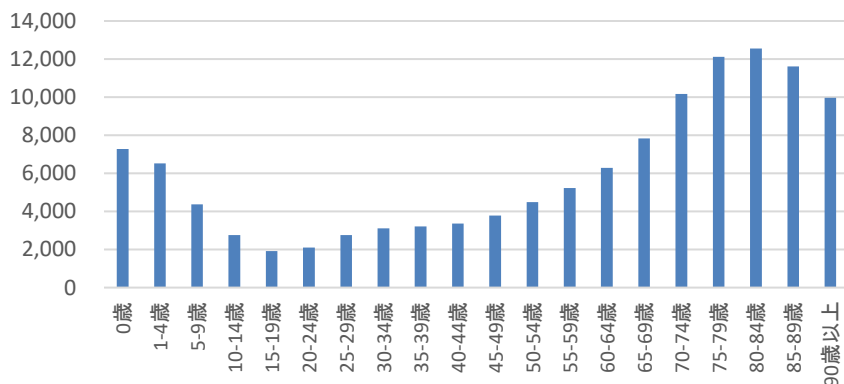
※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。

医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い

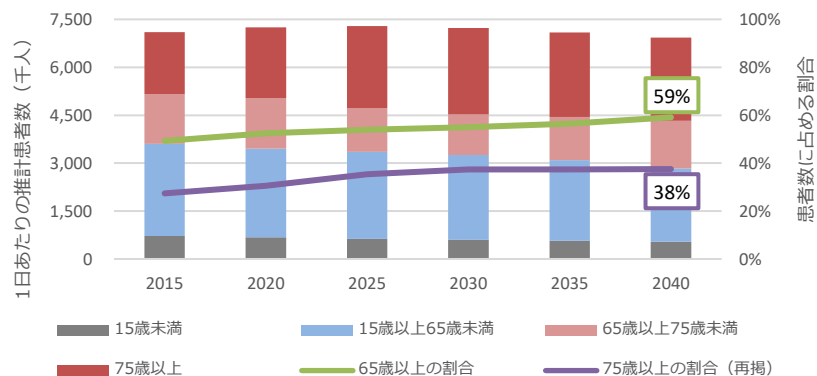
令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 全国での外来患者数は2025年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続的に上昇し、2040年には約6割となるが見込まれる。
- 既に2020年までに217の医療圏では外来患者数のピークを迎えていると見込まれる。

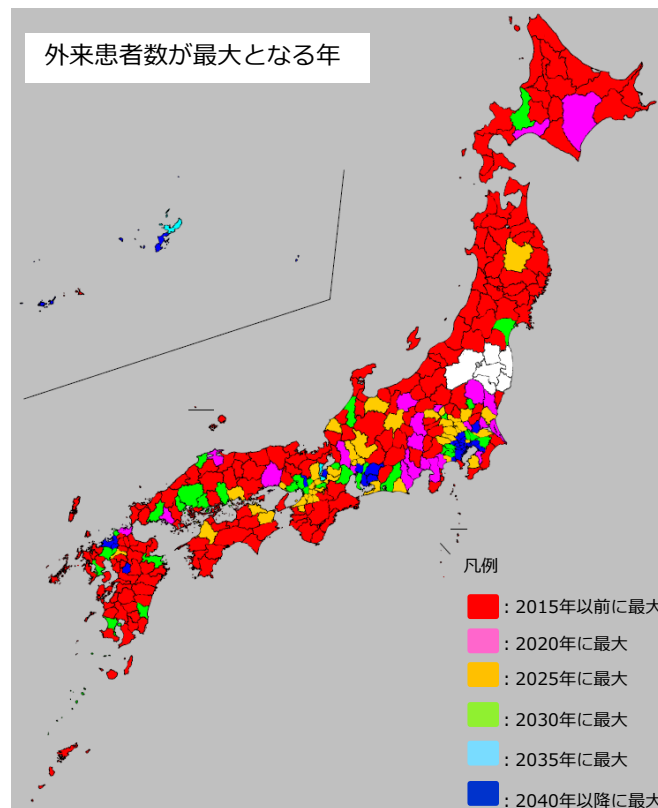
外来受療率（人口10万対）



外来患者数推計



外来患者数が最大となる年



出典：患者調査（平成29年）「受療率（人口10万対）、入院－外来×性・年齢階級×都道府県別」
 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※「外来」には「通院」「往診」「訪問診療」「医師以外の訪問」が含まれる。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用いて算出。

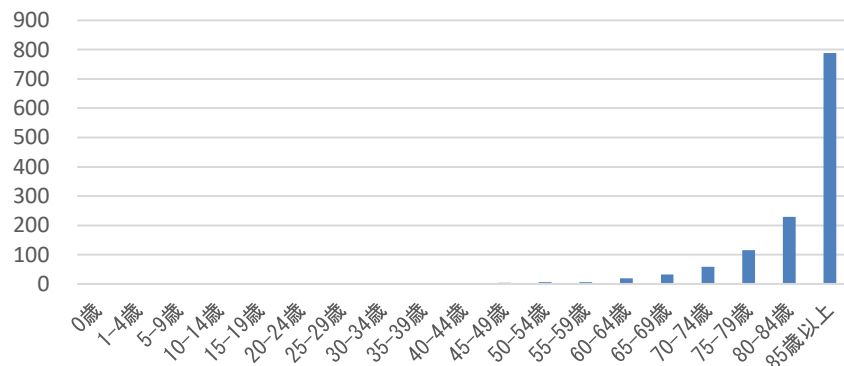
※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。

医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する

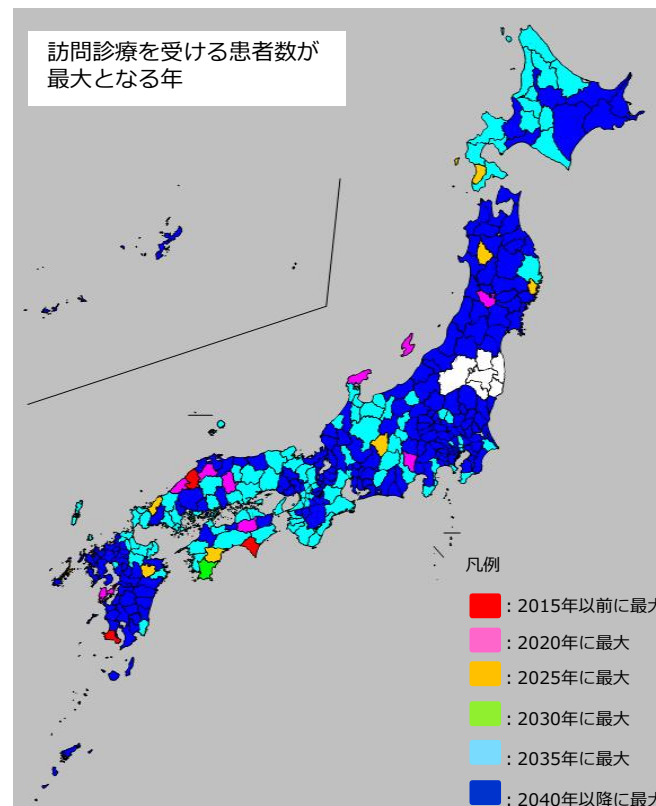
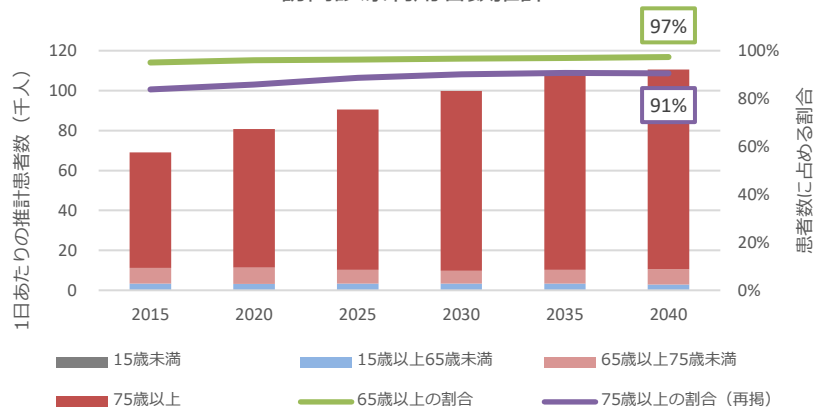
令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 全国での在宅患者数は、2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。
- 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に203の二次医療圏において在宅患者数のピークを迎えることが見込まれる。

訪問診療受療率（人口10万対）



訪問診療利用者数推計



出典：患者調査（平成29年）「推計患者数、性・年齢階級×傷病小分類×施設の種類・入院－外来の種別別」
「推計外来患者数（患者所在地）、施設の種類・外来の種別×性・年齢階級×都道府県別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

※ 病院、一般診療所を対象に集計。

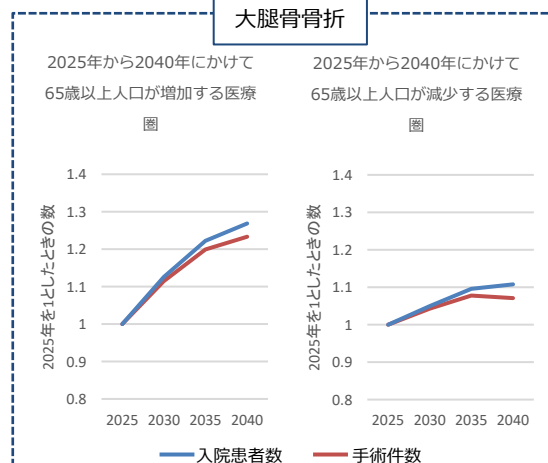
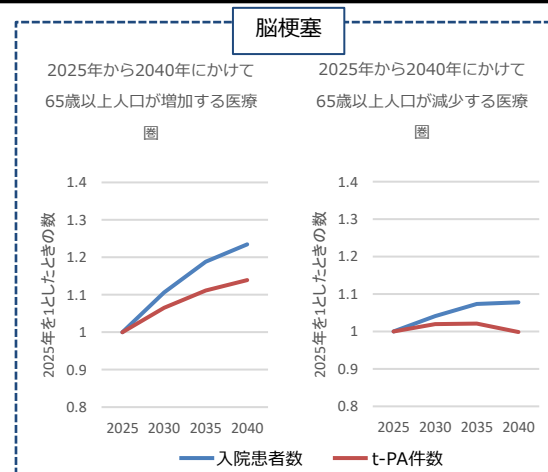
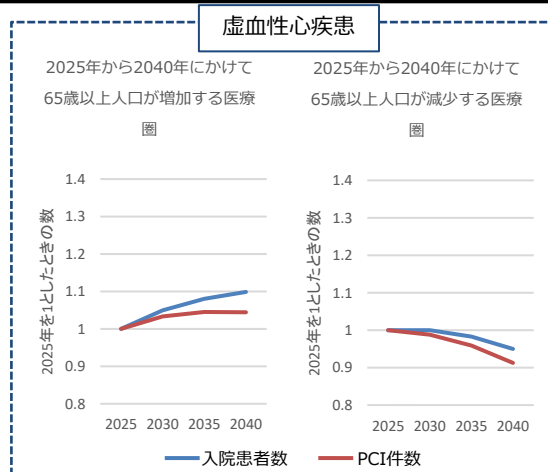
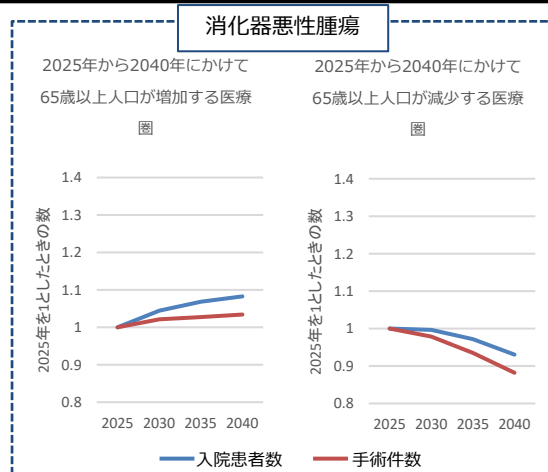
※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用いて算出。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について集計。 42

医療需要の変化④ 超高齢化・人口急減で、急性期の医療ニーズが大きく変化する

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が増加する2次医療圏(132の医療圏)では、急性期の医療需要が引き続き増加することが見込まれるが、がん・虚血性心疾患・脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療の件数は増加しないことが見込まれる。また、大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は大幅な増加が見込まれる。
- 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が減少する2次医療圏(197の医療圏)では、がん・虚血性心疾患の入院患者数の減少が見込まれる。脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療の件数は増加しないことが見込まれる。また、大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は増加が見込まれる。



出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）（2019年度分、医政局において集計）

患者調査（平成29年）「入院受療率（人口10万対）、性・年齢階級×傷病分類」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和2年1月1日現在）」

※ 入院患者数は、各疾患の都道府県ごとの入院受療率に二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 手術件数・PCI件数・t-PA件数は、NDBの集計（下記定義による）による実績値から、令和2年1月1日時点での住民人口を用いて都道府県ごとの受療率を算出し、二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 消化器悪性腫瘍の手術件数とは、消化管及び肝胆膵等にかかる悪性腫瘍手術の算定回数の合計である。

※ 虚血性心疾患のPCI件数とは、「経皮的冠動脈形成術」「経皮的冠動脈ステント留置術」等の算定回数の合計である。

※ 脳梗塞のt-PA（アルテプラゼによる血栓溶解療法）件数とは、「超急性期脳卒中加算」の算定回数の合計である。

※ 大腿骨骨折の手術件数とは、「人工骨頭挿入術（股）」の算定回数の合計である。

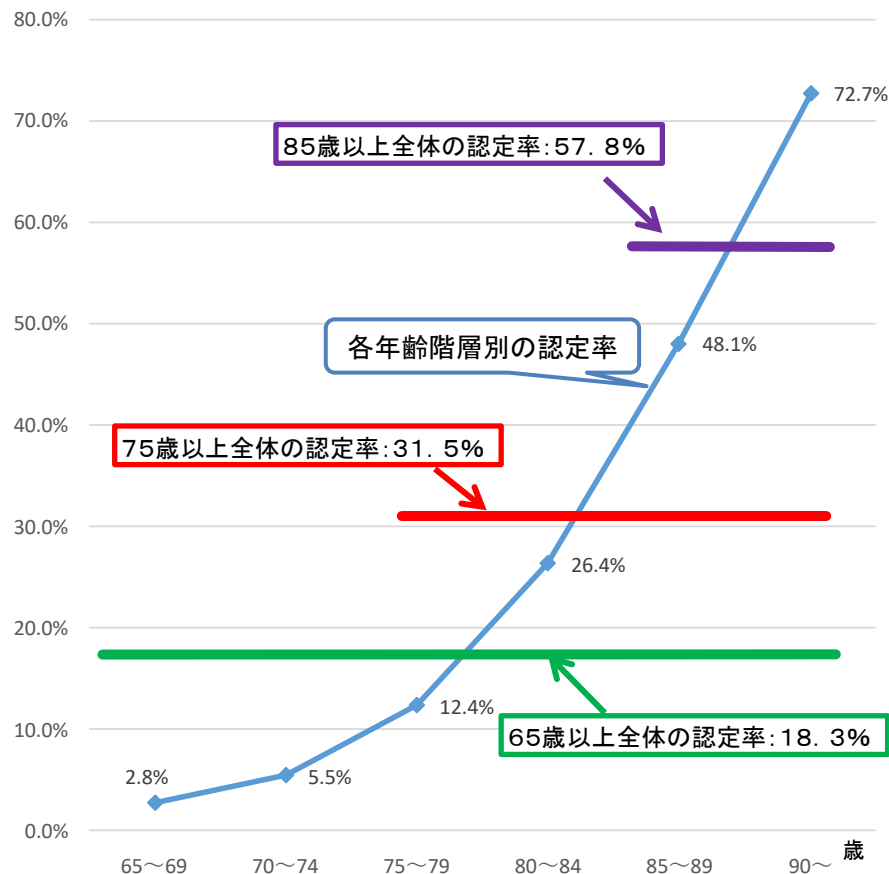
※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について推計。

医療需要の変化⑤ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

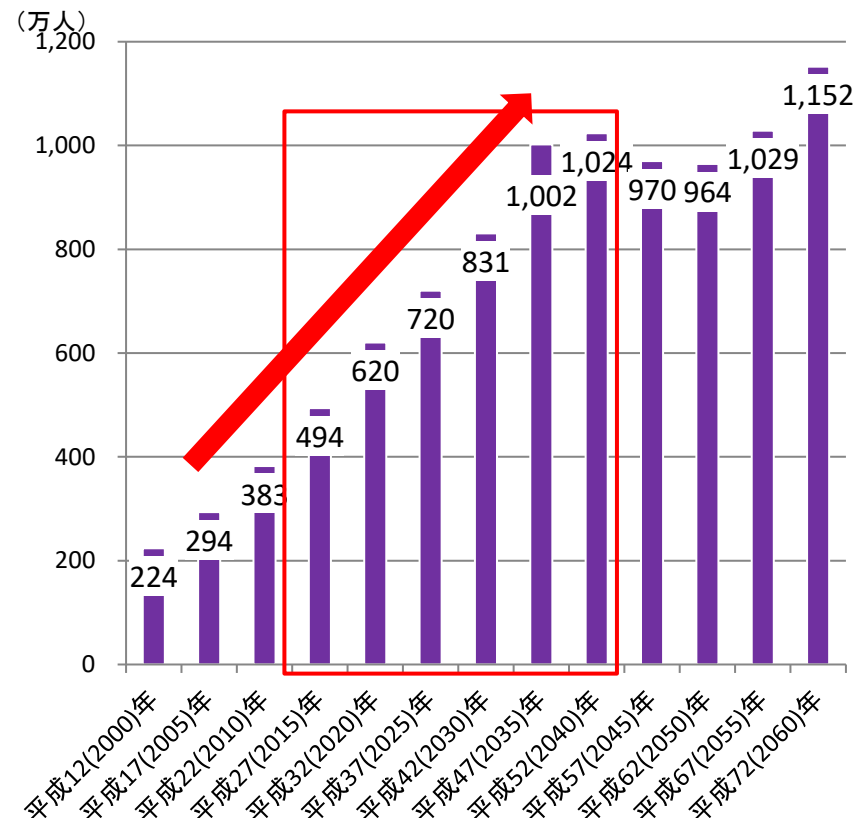
- 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
- 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

年齢階級別の要介護認定率



出典: 2020年9月末認定者数(介護保険事業状況報告)及び2020年10月1日人口(総務省統計局人口推計)から作成

85歳以上の人口の推移

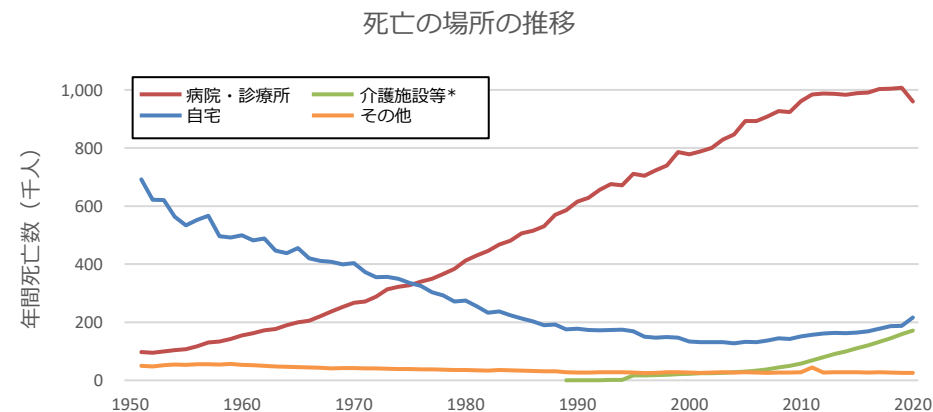
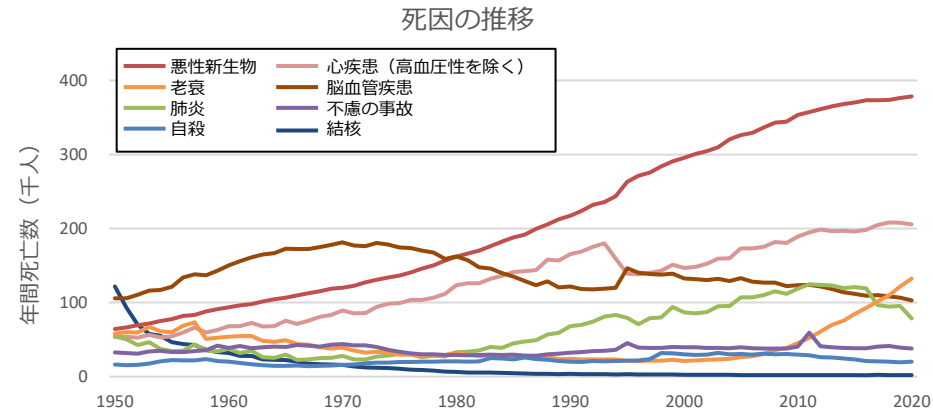
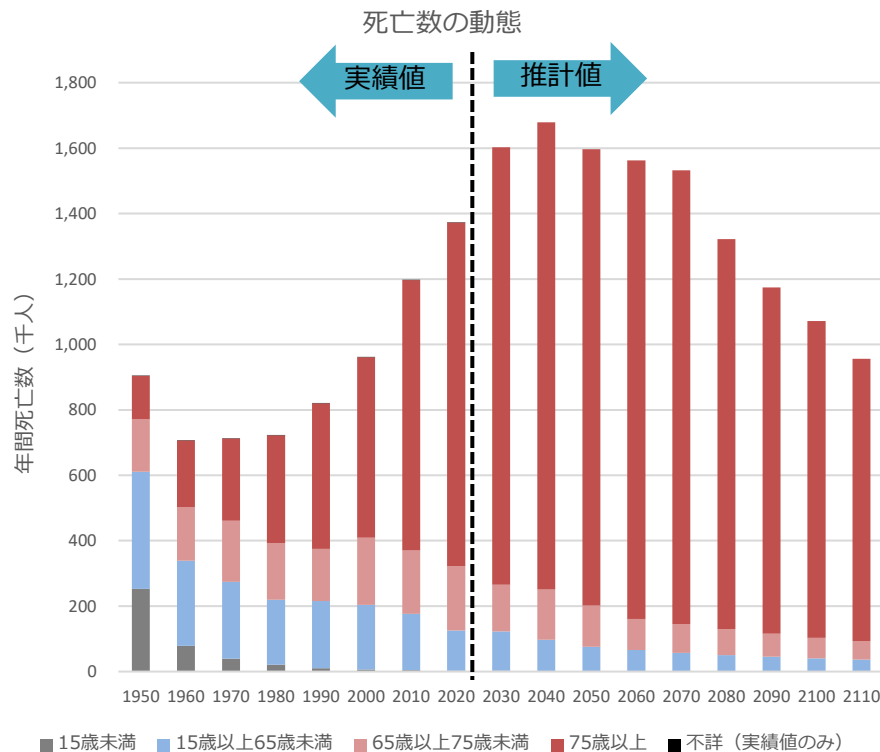


出典: 将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成29年4月推計)出生中位(死亡中位)推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」(国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口)

医療需要の変化⑥ 死亡数が一層増加する

令和4年3月4日 第7回第8次医療計画等に関する検討会 資料1

- 死亡数については、2040年まで増加傾向にあり、ピーク時には年間約170万人が死亡すると見込まれる。
- 死因については、悪性新生物・心疾患とともに、老衰が増加傾向にある。
- 死亡の場所については、自宅・介護施設等が増加傾向にある。



出典：国立社会保障・人口問題研究所「性・年齢（5歳階級）別死亡数」「出生中位（死亡中位）推計：男女年齢4区分別死亡数（総人口）」、厚生労働省「人口動態統計」

*介護施設等：介護医療院、介護老人保健施設、老人ホーム

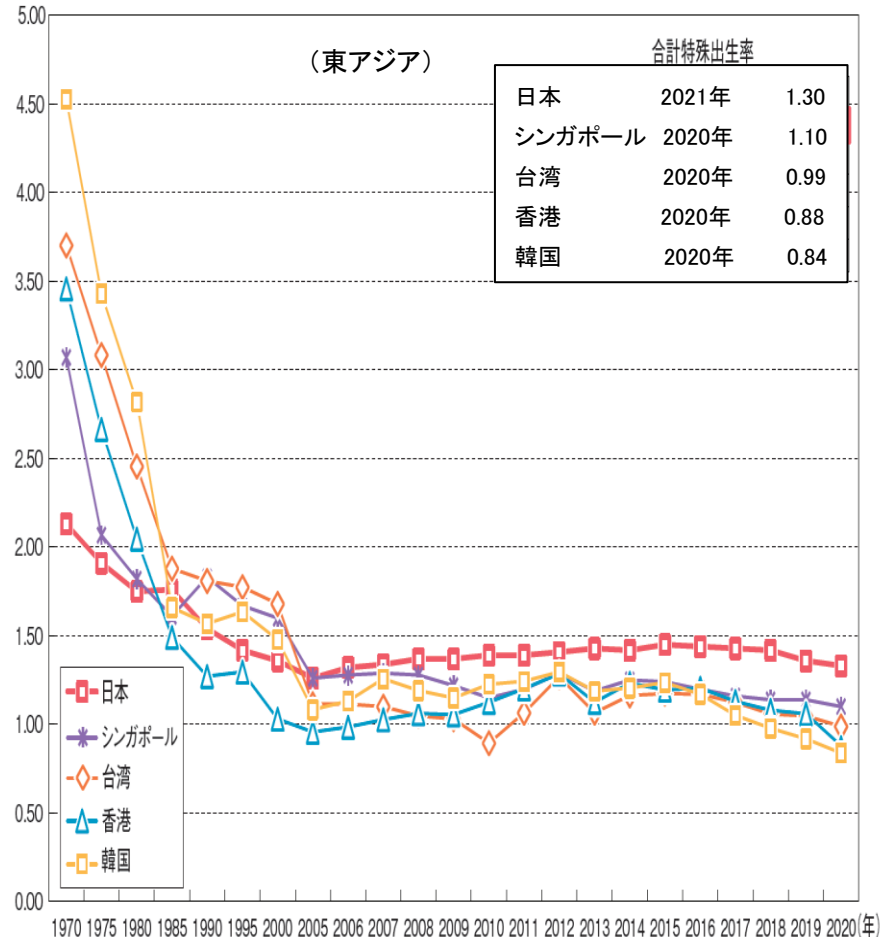
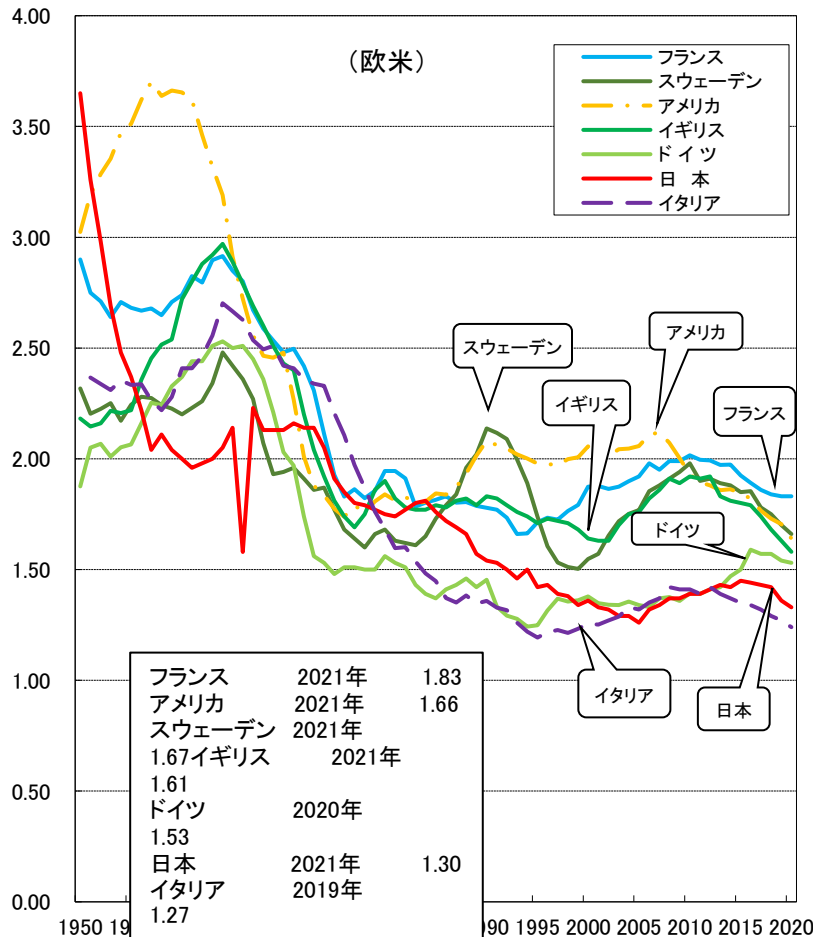
※ 2020年までは実績値、2021年以降は推計値。

各国の出生率の動向

○スウェーデンやフランスの出生率は、直近はコロナの影響で低下しているが、高い水準を維持(2021年には出生率は反転)。ドイツの出生率の動向が注目される。

○近年、日本のみならず、韓国や中国など東アジア諸国の出生率の低下が著しい。

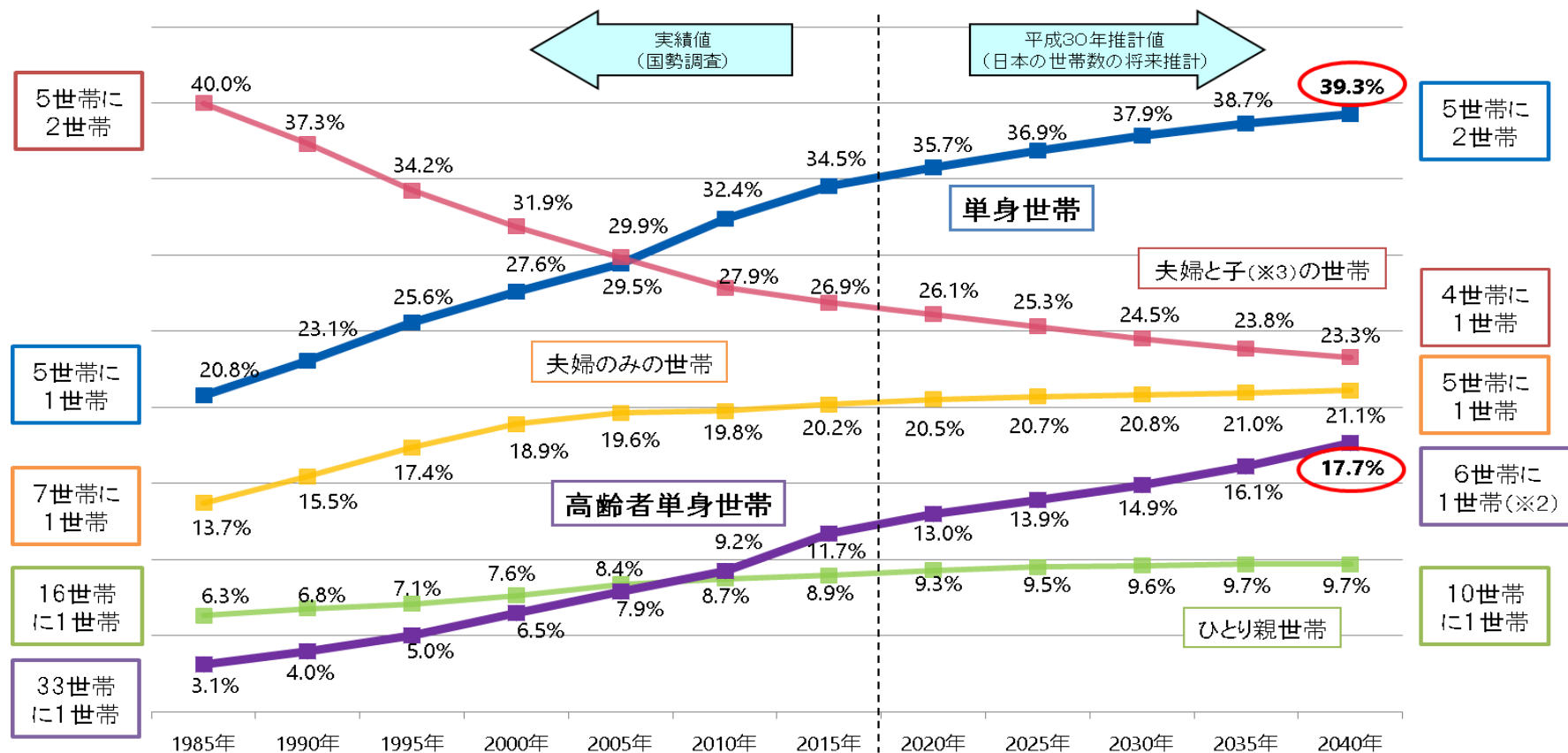
諸外国の合計特殊出生率の動き



資料：諸外国の数値は1959年までUnited Nations "Demographic Yearbook" 等、1960～2018年はOECD Family Database、2019年は各国統計、日本の数値は厚生労働省「人口動態統計」を基に作成。

「個人化（単身化）」の進行

- 単身世帯、高齢者単身世帯、ひとり親世帯ともに、今後とも増加が予想されている。
- 単身世帯は、2040年で約4割に達する見込み。（全世帯数約5,333万世帯（2015年））



出典：総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2018年推計）」

感染症対策（抜粋）

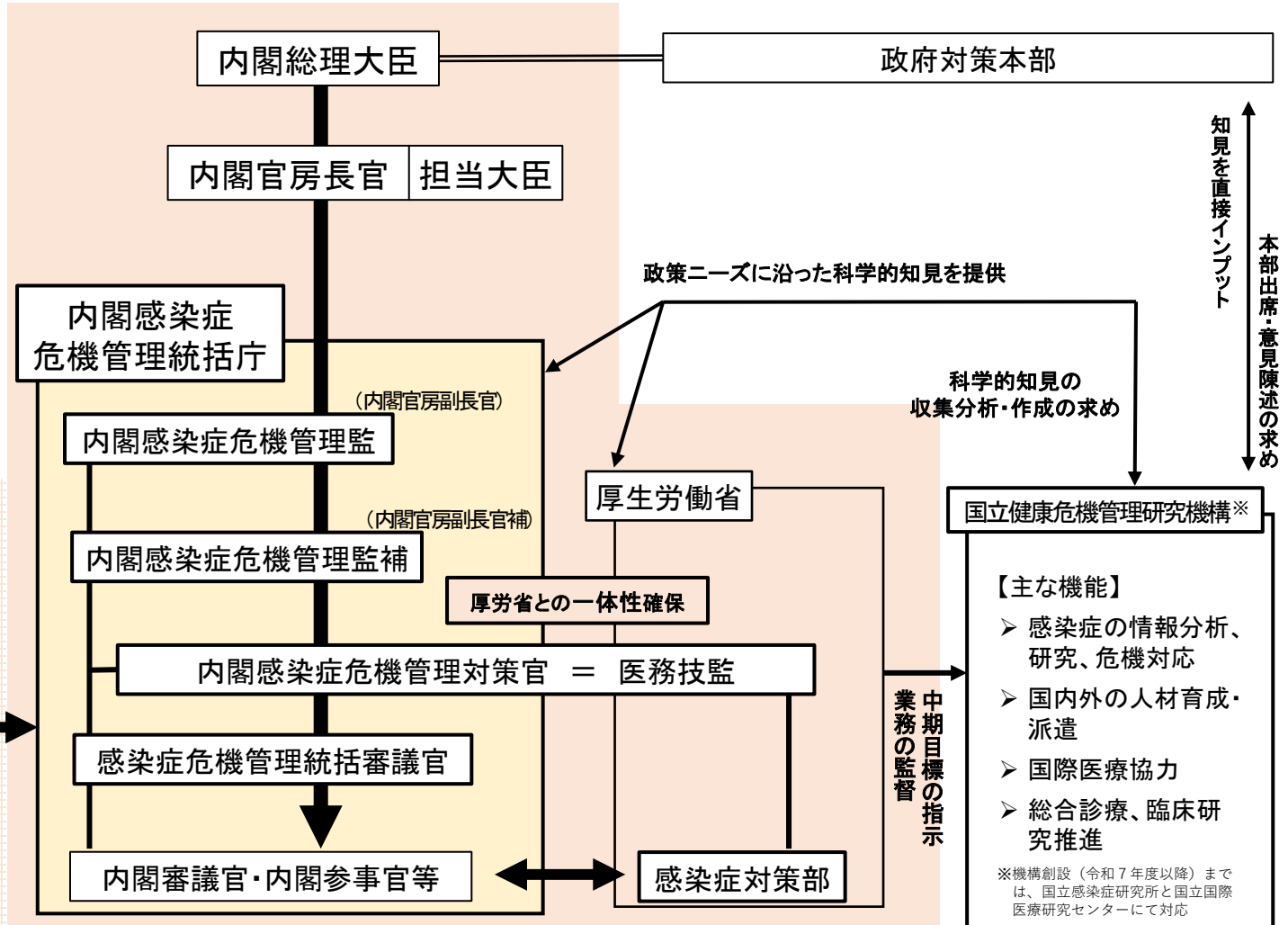
内閣感染症危機管理統括庁の発足式①

令和5年9月1日(金)、内閣感染症危機管理統括庁発足式が行われ、総理と後藤大臣、藤丸副大臣、鈴木政務官が出席し、看板かけおよび職員への訓示を行いました。



○ 感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機に迅速・的確に対応できる体制を整えるため、内閣法を改正し、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置（設置日：令和5年9月1日）

★統括庁が総理・長官を直接支えて、感染症対応の方針の企画立案、各省の総合調整を一元的に所掌



★医務技監を結節点として、感染症対策部や、国立健康危機管理研究機構の専門的知見の提供を確保

内閣危機管理監

★感染症に係る危機管理は、統括庁が一元的に所掌し、実施。

※内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理について、統括庁に協力

新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の概要

- **新型インフルエンザ等対策政府行動計画**は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、**平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものとして、2013年に策定**（2017年に一部改正）
- 今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、**初めて政府行動計画を抜本的に改正**
「内閣感染症危機管理統括庁」や「国立健康危機管理研究機構（JIHS）」の設置や、
国・都道府県の総合調整・指示権限拡充によるガバナンス強化、医療機関等との平時の協定締結による準備体制の確立等の制度改正も反映し、**新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応**できる社会を目指す。
- 次の感染症危機においては、**本政府行動計画を参考に、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、基本的対処方針を速やかに作成し、対応**

1. 平時の準備の充実

- 「訓練でできないことは、実際でもできない」。
国や地方公共団体等の関係機関において、**平時より実効性のある訓練を定期的に実施**し、不断に点検・改善
- 感染症法等の計画に基づき、自治体は関係機関と協定を締結。**感染症発生時の医療・検査の体制立ち上げ**を迅速に行う体制を確保
- **国と地方公共団体等、JIHSと地方衛生研究所等との間の連携体制**やネットワークの構築

2. 対策項目の拡充と横断的視点の設定

- 全体を3期（準備期、初動期、対応期）に分けて記載
- 6項目だった対策項目を**13項目に拡充。内容を精緻化**
- 特に**水際対策や検査、ワクチン**などの項目について、従前の政府行動計画から記載を充実するとともに、偏見・差別等の防止や偽・誤情報対策も含めた**リスクコミュニケーションのあり方**などを整理
- 5つの横断的視点※を設定し、各対策項目の取組を強化

※ 人材育成、国と地方公共団体との連携、DXの推進、研究開発支援、国際連携

3. 幅広い感染症に対応する対策の整理と柔軟かつ機動的な対策の切り替え

- **新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定**して対策を整理
 - 状況の変化※に応じて、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえ、**柔軟かつ機動的に対策を切り替え**
- ※ 検査や医療提供体制の整備、ワクチン・治療薬の普及、社会経済の状況等

4. DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

- 予防接種事務のデジタル化・標準化や電子カルテ情報の標準化等の医療DXを進め、**国と地方公共団体間等の情報収集・共有・分析・活用の基盤整備**
- 将来的に電子カルテと発生届の連携や臨床情報の研究開発への活用等

5. 実効性確保のための取組

- 行動計画に沿った取組を推進するとともに実施状況を**毎年度フォローアップ**※
- 感染症法等の計画等の見直し状況やこれらとの整合性等を踏まえ、**おおむね6年ごとに改定**

※特に検査・医療提供体制の整備、PPE等物資の備蓄状況等は見える化

1. 病原体

- ハンタウイルス科オルソハンタウイルス属のウイルス（アンデスウイルス等）
※ハンタウイルスには多数の種があり、その一部が疾患の原因となる。

2. 感染経路

- 病原体を保有するげっ歯類の排泄物を含む粉じんの吸入、汚染された食物の喫食。
- ハンタウイルスのうち、アンデスウイルスのみ、限定的なヒトーヒト感染が過去に報告。
ただし、濃厚な飛沫・接触曝露を介した限定的な伝播であり、感染者と接触者の適切な管理により制御可能とされている。
- 今般のクルーズ船事案におけるヒトーヒト感染の感染力等については、WHO等により疫学調査を実施中。

3. 症状

- 潜伏期間は1週間から5週間程度（通常約2週間）。
- 発熱や咳、筋肉痛などを呈し、嘔吐や下痢を伴うこともある。急速に症状が進行し、呼吸不全を呈し死亡することがある。
致命率は約40%から50%である。

4. 発生状況

- 北米、中南米で発生がみられる一方、日本国内では患者発生の報告はない。（日本にはアンデスウイルスを媒介するげっ歯類は存在しない）
※腎障害等を引き起こす別のハンタウイルスを原因とする腎症候性出血熱については、過去（60年代等において）我が国でも発生が確認されている。

5. 診断・治療・予防

- 診断：血液、肺組織からのウイルスの分離・同定等。
- 治療：特異的な治療法はなく、対症療法が中心である。
- 予防：流行地域ではげっ歯類との接触を避ける。環境を清潔に保つ。食品は蓋などをして適切に保管する。国内で承認されたワクチンはない。

オランダ国籍クルーズ船におけるハンタウイルス肺症候群の発生事案について

事案の概要

※ 5月12日 21:00時点

- 当該船舶は2026年4月1日にアルゼンチンを出港し、南大西洋を横断する航路を取っており、西アフリカ沖の島国カーボベルデを目指して、セントヘレナ等の南大西洋の様々な島に寄港
- 計147名（乗客88名、乗組員59名、計23カ国籍）が乗船、日本人1名も含まれる。
- 船舶はカーボベルデ沖（西アフリカ）を出航後、5月10日にカナリア諸島に着岸
- 5月11日、日本人1名は、同船を下船後、英国政府手配のチャーター機により英国に到着。
- 同邦人の健康状態に問題はないものの、英国では、同邦人を含め下船した方は、英医療施設にて検査等を受けた後、同国保健当局による最大45日間の健康観察等を受けることになる。
- 5月12日、乗客は下船済み。

（4月6日、最初の患者が発生。4月24日に30名以上がセントヘレナ島にて下船）

- 5月2日、WHOは、オランダ国籍のクルーズ船ホンディウス号内で発生した、原因不明の重症急性呼吸器疾患（SARI）のクラスターについての通報を受理。
- 5月2日、患者1名においてハンタウイルス感染が確認。（5月5日に2人目）
- 5月7日、感染者からハンタウイルスの一種であるアンデスウイルスが確認
- 5月12日 これまでに11例が報告され、うち3名が死亡。11例中9例（うち死亡2例）はハンタウイルスの感染が確認され、残る2例（うち死亡1例）は可能性例*。

*可能性例：疫学的関連及び症状等を有するが検査が実施されていない症例。

※航海中、あるいはアルゼンチンでの乗船前における乗客の現地野生動物との接触状況（排泄物も含む）は、現時点では不明（感染原因についても調査中）。



クルーズ船の航路（テレビ朝日）

症例	確定例	可能性例*	計
生存者	7	1	8
死亡者	2	1	3
計	9	2	11

症例の症例分類および転帰別分布

厚生労働省の対応

- ・ 検疫所で注意喚起（南米からの帰国者で体調異常の方に、げっ歯類との接触の有無等を確認し、必要に応じて医療機関への受診を勧奨（2026/5/4）
- ・ JIHSのリスク評価（国外航行中のクルーズ船におけるハンタウイルス感染症事例について）公表に関してプレスを行い、当省HPに掲載（2026/5/6）

感染症対策

● 国内外問わず感染症は常に発生

- ▣ 新型コロナ以降、流行状況に変化（マイコプラズマ、百日咳、伝染性紅斑（リンゴ病）等）
- ▣ 国外におけるワクチン接種状況やインバウンド増も国内に影響あり（麻疹など）
- ▣ 米国の牛の間での鳥インフルエンザの流行、アジア地域における鳥インフルエンザ
- ▣ コンゴ民主共和国等におけるエムポックスの流行
- ▣ 里山などに住んでいたクマ等が人里に出没（ダニ媒介SFTSなど）
- ▣ 気候変動（温暖化）の影響
 - ✓ 蚊等の生息区域の変化（デング熱、ジカ熱、チクングニア等）
 - ✓ 洪水・干ばつの増加（コレラ、細菌性赤痢等）
 - ✓ 永久凍土の融解（炭疽菌、巨大ウイルス等）



● 人類の歴史は感染症との闘いとの歴史

- 3点セットの「武器」を平時から官民が連携して磨き上げる必要
- 感染症インテリジェンスの能力をあげるには、「人材」の育成が肝
- 感染症のリスクコミュニケーションでは特に「信頼」が重要

最後に

日本への期待（私見）

- 政策

- 国際保健問題を国の重要施策に位置づけ、国際アジェンダ(G7・G8, G20, 国連における種々の会議や国際会議等)としてモメンタムを維持

- 人

- 日本は海外の人にとって憧れの国
- 日本人のきめ細やかさ（調整力）・責任感・誠実さは誇るべきもの
※コミュニケーションに課題

- 経験

- 過去の経験
（結核対策（保健所），母子保健（母子手帳），国民皆保険制度等）
- これからの経験（世界でもっとも高齢者の割合が高い国）
- 民間企業の高い技術力・信頼力
- 情報発信・共有（言葉の問題あるが，共有されないのはもったいない）
※ランセットへの発信

- 金

- ODA世界3位に下がったものの，引き続きドナー国として大きな期待
- 民間企業のCSR活動，グローバル市場への進出（調達活動含め）

国際保健の世界で働いて感じること（私見）

- 世界の動向を知らずに国内行政を進められない。
 - 特に感染症対策などは地球の反対側で起きていることが、翌日には日本で起きる可能性あり
- きめ細かい対応は世界でこそ有効。
（A国とB国の大臣がC国で会う場合など）
- 世界には公衆衛生分野で活躍している仲間がたくさんいる。
（国連職員，国境なき医師団，難民キャンプ，紛争地域，NGO etc）
- 「公衆衛生」分野を改善するためには，様々な分野・関係者との粘り強い調整が不可欠。（Be passionately professional!）
- 多様性（Diversity）と多様性を束ねるリーダーシップの重要性。

若い皆さんへ

- レジリエンス
 - 自己肯定感
 - 環境適応能力
 - 人間関係
 - 社会貢献
 - 生活習慣
- リーダーシップ
- 多様性
- 自分を磨く環境
- プライベート（家族）を大切に
- 自分のベクトルを意識